U.F. 0124. INTERRELACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA PERSONA DEPENDIENTE Y SU ENTORNO

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE RELACIONADOS CON LOS PRINCIPALES TRASTORNOS GENERALES

1.1. DISCAPACIDAD MENTAL

La discapacidad mental (el retraso mental) se ha definido históricamente como una categoría diagnóstica referida a las personas con una pobre ejecución en los test de inteligencia y en el aprendizaje y que mostraban dificultades de competencia para manejar con independencia actividades de su propia vida y asuntos.

En 2002 se define como una *discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años.*

Vamos a explicar un poco la definición:

- La capacidad intelectual se mide con el Cociente Intelectual (CI), se considera inferior a la media y por tanto que existe discapacidad si es igual o menor a 70. Así mismo, y según la puntuación obtenida, se clasifica en discapacidad mental leve o ligera, moderada, grave o severa y profunda.

- Al hablar de conducta adaptativa nos referimos a las habilidades aprendidas para desenvolverse en la vida diaria. Estas habilidades pueden ser conceptuales (cálculos matemáticos, leer, escribir..), sociales (capacidad para comunicarse, ser responsable, respetar las normas) y prácticas (habilidades de autocuidado, vestirse, arreglarse, comprar...).

- Debe de aparecer antes de los 18 años, sino hablaríamos de demencia o de enfermedad mental pero no de discapacidad intelectual.

En la actualidad no se emplean los términos "deficiencia" o "retraso", sino "discapacidad", destacando la existencia de una capacidad, aunque sea disminuida.

Atendiendo a las áreas de funcionamiento, en la discapacidad mental encontramos un enlentecimiento generalizado:

- Area cognitiva: Es posible que se manifieste el pensamiento concreto (en vez de un desarrollo hacia la abstracción), egocentrismo, distractibilidad y dificultades de atención entre otras.
- Area emocional: Presentan ciertas dificultades para expresar y percibir afecto. En ocasiones estas dificultades pueden estar originadas por impedimentos físicos (hipotonía, hipertonía...)
- Area comportamental: Dificultades de adaptación. Las interacciones normales diarias pueden poner a prueba sus capacidades cognitivas y las habilidades de afrontamiento. En estos casos, el descontrol y la frustración pueden conducir a actos violentos (autolesivos) o destructivos.

Etiología o Factores que la causan:

Pueden ser genéticas o adquiridas:

a) genéticas : (marcadas genéticamente) causa orgánica, por ejemplo el síndrome Down.
b) Adquiridas: según en el momento en el que aparecen pueden ser prenatales (antes de nacer), perinatales (durante el nacimiento) y postnatales (después del nacimiento). Por ejemplo enfermedades padecidas por la madre durante el embarazo que originan discapacidad intelectual, falta de oxigeno durante el parto, o traumatismos craneoencefálicos, intoxicaciones o tumores.

Las alteraciones de la comunicación y el lenguaje van a depender del nivel previo de inteligencia que presenten y de la atención temprana que hayan recibido. Por tanto, éstas pueden oscilar desde la mínima afectación del lenguaje hasta el mutismo.

Características de la comunicación y el lenguaje

- El desarrollo del lenguaje dependerá del grado de discapacidad intelectual (cuanto más leve sea la discapacidad mayor será el desarrollo del lenguaje y la comunicación).
- Las limitaciones comunicativas influirán en el aprendizaje y desarrollo de las otras funciones cognitivas (memoria, atención, razonamiento...)
- Suelen presentar un procesamiento lento de la información y de la capacidad de reacción, lo que dificulta el mantenimiento de las conversaciones.
- Dificultad para comprender y producir mensajes verbales.
- Suelen presentar problemas de aprendizaje: para comprender conceptos abstractos, adquirir vocabulario nuevo... por lo que en muchos casos las conversaciones se limitan a hechos cotidianos.

- Algunas personas con discapacidad intelectual presentan malformaciones en los órganos implicados en el habla (boca, lengua, dientes,...) lo cual obstaculiza el lenguaje oral causando disglosias (dificultad para articular los fonemas)
- Pueden presentar disartrias cuando las dificultades son de articulación, por ejemplo, cuando hay lesiones en el Sistema Nervioso Central.

- Muchas veces presentan falta de iniciativa para interactuar verbalmente, problemas y dificultades en la expresión de necesidades, lo cual les dificulta las relaciones interpersonales.

1.2. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI)

El término parálisis cerebral hace referencia a un conjunto de incapacidades motoras causadas por un daño en el cerebro del niño ocurrido en el período prenatal, perinatal o posnatal.

La **PCI** es una lesión del Sistema Nervioso Central (SNC), permanente y NO progresiva. Se manifiesta en afectación de la función motora, en el tono, la postura y el movimiento, además puede ser causa de alteraciones en las funciones cognitivas superiores.

Tipos de PCI:

- **Espástica**: (rigidez muscular) es la forma clínica más frecuente. Estas personas tienen un tono muscular exagerado llamado "hipertonía" (movimientos bruscos), la parte afectada del SNC suele ser la corteza cerebral.
- **Atetósica**: (disquinética o distónica) el tono varía entre hipotonía e hipertonía. Las personas afectadas presentan movimientos involuntarios: muecas, contorsión de los miembros, dificultad en el habla, son frecuentes las dificultades de audición. La lesión está en la parte central del cerebro.
- **Atáxica:** afectación con hipotonía (disminución del tono muscular), falta de coordinación del movimiento y trastornos del equilibrio en diferentes grados, marcha insegura. La lesión se localiza en el cerebelo.
- **Mixta**: la persona presenta características de los tipos anteriores, combinaciones de distintos trastornos motores con diversos tipos de alteraciones del tono.

Etiología o Factores que la causan:

Pueden ser diversas y se clasifican según el momento de aparición. Así

- **Prenatales:** enfermedades infecciosas padecidas por la madre durante el embarazo (por ejemplo la rubéola), el tabaco, alcohol u otros tóxicos.
- **Perinatales:** falta de oxígeno en el parto, o sufrimiento de traumatismos craneales en el momento de nacer.
- **Postnatales:** traumatismos craneales, infecciones como meningitis, accidentes cardiovasculares durante los primeros años de vida.

Las personas con PCI sufren alteraciones del tono muscular y en la realización de movimientos voluntarios, pueden padecer además déficits auditivos y visuales, problemas en la deglución y masticación, y a veces (no siempre) discapacidad intelectual. El lenguaje y la comunicación están afectados.

Características de la comunicación y del lenguaje

- La producción oral está afectada por la falta de control de los órganos implicados en el habla (músculos faciales, lengua, boca..)
- En ocasiones la respiración es irregular y descoordinada, lo que provoca alteraciones en la voz, bloqueos, interrupciones o retraso en el inicio de las vocalizaciones.
- El habla es muy imprecisa, con pausas colocadas de modo extraño y se acompaña de movimientos corporales que no pueden controlar y que tampoco aportan apoyo a la comunicación.
- Sufren alteraciones en la intensidad y el timbre de la voz.
- Presentan disartrias (dificultades en la articulación de las palabras).
- El ritmo también está afectado , suele ser lento, irregular y monótono.
- Limitaciones en los movimientos corporales, lo que va a afectar a las funciones cognitivas y el desarrollo del lenguaje.
- Dificultades para producir mensajes (para expresarse).
- Dificultades para comprender , interpretar y elaborar una respuesta (si además hay una discapacidad intelectual asociada).
- La comunicación con las personas con PCI mejora con tratamientos de logopedia, donde se trabajará la articulación, respiración, el ritmo, la entonación.
- Muchas veces es preciso utilizar SAAC (Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación) (los veremos más adelante).

1.3. AUTISMO

El **autismo** se considera un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), trastorno permanente que se manifiesta en los primeros años de vida y subsiste en la edad adulta, se caracteriza por un desinterés por la comunicación (verbal y no verbal) y dificultades graves para la interacción social, y comportamientos y actividades estereotipados (movimientos repetitivos, preocupación persistente por las partes de un objeto).

Etiología o Factores que la causan:

Aún no están claras, pero se considera la combinación de factores genéticos y del entorno biológico prenatal y postnatal.

Las dificultades de las personas con autismo son importantes y perduran a lo largo del tiempo. Pocas personas con autismo llegan a desarrollar una vida normal. La mayoría requiere atención y supervisión de otra persona a lo largo de su vida. Los síntomas pueden variar de una persona a otra. En general, presentan escasa empatía, lo que dificulta las interacciones interpersonales, muestran una capacidad disminuida para comprender las acciones y emociones del otro. Muchas personas con autismo muestran aislamiento y pasividad por la relación con los demás. Aparecen también comportamientos repetitivos, movimientos y conductas reiterativas (girar en círculos, aleteo de manos,...), miedo excesivo, comportamientos autolesivos (en ocasiones como medio de estimulación), insensibilidad al dolor, etc.

En definitiva, el autismo es un trastorno que desconecta a la persona del mundo, y es muy complicado que responda a estímulos tanto internos como externos.

Características de la comunicación y del lenguaje:

- Verbalización reducida.
- Falta de imaginación para anticipar o imaginar lo que el otro está pensando.
- Algunos presentan "ecolalias" (repetición de palabras o frases que le acabamos de decir: ej. "¿cómo te llamas?" Y él repite " como te llamas".
- A menudo retraso del lenguaje o incluso ausencia del lenguaje.
- Dificultades para mantener conversaciones.
- Alteraciones en el ritmo, volumen, velocidad y entonación.
- Problemas en la regulación de los turnos de palabra.
- Mirada huidiza (no mantiene el contacto ocular durante la conversación)
- A veces incapacidad para comprender el lenguaje oral.
- Mala articulación verbal.
- Dificultades para encontrar la relación palabra-concepto (significado).
- Mutismo selectivo ante determinadas situaciones.
- Dificultades en el uso del lenguaje con fines comunicativos (trastorno semántico—pragmático). Este trastorno se hace visible en la falta de regulación de los turnos de intervención, la falta de habilidad para iniciar y terminar conversaciones, la comprensión del doble significado del lenguaje (utilizado en los chistes), en la falta de petición de aclaraciones para comprender los mensajes.

1.4. PARKINSON

La enfermedad del PARKINSON es un trastorno degenerativo de las neuronas que afecta a la zona del cerebro que controla el tono muscular, la postura y la coordinación de movimientos. Los síntomas no afectan en el mismo grado a todas las personas que lo padecen, ni el pronóstico ni la evolución son los mismos. La enfermedad está asociada a rigidez muscular, alteraciones en la marcha, falta de coordinación de movimientos y, en algunas ocasiones (no todas) a demencia.

La edad de inicio está entre los 40 y 70 años (aunque hay casos donde la edad de inicio es anterior).

Etiología o Factores que la causan:

Son todavía desconocidos, aunque parece ser de origen ambiental en combinación con una predisposición genética.

Síntomas característicos de la enfermedad:

- Temblor en reposo (o descanso del movimiento), que afecta con mayor frecuencia a las extremidades (habitualmente comienza en las superiores). Disminuye con los movimientos intencionales.

- Lentitud de movimientos (bradicinesia) en actividades que requieren precisión (escribir). Pérdida o disminución de los movimientos automáticos y espontáneos (bloqueos). Este síntoma es uno de los principales obstáculos con los que se enfrenta la persona para la realización de las actividades de la vida diaria, debido a que su ejecución se torna más dificultosa y requiere mucho más tiempo.

- Espasticidad o rigidez muscular, que se manifiesta en dolor muscular y articular. Es característica la rigidez facial, la inexpresión.

- Aparición de trastornos posturales, alteración de la marcha que se caracteriza por pasos cortos y rápidos y por una postura inclinada hacia delante.

Características de la comunicación y del lenguaje:

- Los órganos fonatorios se ven afectados por la progresiva rigidez y alteraciones del tono muscular, lo que provoca alteraciones en la articulación (DISARTRIAS), sustitución , omisión o repetición de fonemas.
- El habla es lenta, débil y a veces no se entiende. La voz se vuelve monótona, ronca y con temblor vocal, pérdida de inflexiones naturales del lenguaje.

- Dificultades para iniciar el habla, seguido de una brusca aceleración del ritmo y acortamiento de las palabras y terminando con repeticiones en un tono y volumen bajo.
- Lentitud al responder, aunque esto no significa que haya problemas en la comprensión del mensaje.
- Los músculos faciales y por lo tanto la expresividad del rostro también está afectada (aspecto de máscara) con lo que esto se suma a las dificultades de expresión.
- En cuanto al lenguaje escrito, la letra se vuelve pequeña (micrografía).
- Estos problemas en la comunicación pueden llevar a la persona al aislamiento , la depresión y el desinterés por comunicarse con los demás .

Aspectos a observar y sugerencias para el paciente en procesos de comunicación:

- Tener presente que hablar requiere ahora más atención y esfuerzo.
- Respirar antes de empezar a hablar, haciendo pausas cada pocas palabras.
- Exagerar la pronunciación, como si el interlocutor fuera sordo y necesitase leer los labios.
- Expresar las ideas de forma escueta y con frases concisas.
- Organizar los pensamientos e ideas y estructurar lo que se va a decir.
- Mirar al interlocutor.

Estrategias de comunicación:

- Prestarle mucha atención.
- Decirle que hable palabra a palabra o en frases cortas.
- Decirle que exagere la pronunciación.
- Animar al paciente a usar frases cortas. Darle tiempo para que se concentre antes de hablar.
- Hacerle señales afirmativas de que se entiende lo que está diciendo.

1.5. ALZHEIMER

La enfermedad de **Alzheimer** (EA) es el tipo de demencia más común entre las personas mayores de 65 años (aunque también puede haber casos de personas más jóvenes), seguida de la demencia vascular. Es un síndrome (conjunto de signos y síntomas) producido por la afectación del sistema nervioso central (SNC) que se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones cognitivas superiores. Es degenerativa e irreversible. El impacto depende del estado físico previo del sujeto, modo de vida, carácter...

Etiología o Factores que la causan:

Aún desconocidos, parece que tanto factores genéticos como ambientales están implicados en la aparición de la enfermedad.

Síntomas característicos de la enfermedad:

El síntoma principal suele ser la pérdida de memoria. Otros síntomas: alteraciones del comportamiento y del estado de ánimo, alucinaciones y delirios, ansiedad o depresión, dificultad para realizar ciertos movimientos (apraxia) y para reconocer objetos, lugares y personas (agnosia), desorientación espacial y temporal, etc..

Fases de la enfermedad

Se establecen en función de la gravedad y aparición de los síntomas:

- 1ª fase inicial: Se aprecian fallos de memoria, disminución de vocabulario (falta de palabras, nombres y objetos), dificultades de atención y concentración, trastornos de personalidad y de estado de ánimo (ansiedad o depresión), desorientación en lugares no conocidos, bajo rendimiento laboral. La persona es independiente y puede llevar una vida normal (sus fallos pasan inadvertidos).
- 2ª fase intermedia: trastornos de memoria (inmediata y a largo plazo), alteraciones en el manejo del dinero, apraxias, incapacidad para realizar tareas complejas, desorientación en el tiempo y en el espacio, agnosias (incapacidad para reconocer objetos, caras...) y trastornos del lenguaje. Se precisa supervisión para la realización de las AVD, pero no para el aseo o la comida.
- 3ª fase terminal: Aparece la dependencia y falta de autonomía para la realización de todas las AVD, desorientación total en las tres esferas (tiempo-espacio-persona), pérdida de las habilidades verbales, incontinencia de esfínteres, trastornos de la marcha. Necesitan ayuda constante y permanente.

Características de la comunicación y del lenguaje:

- El lenguaje se ve afectado de forma progresiva: al principio la persona se da cuenta de que tiene problemas para recordar y ello afecta a la forma en que se comunica con los demás. Esto le causa tristeza, inseguridad y frustración.
- Dificultad progresiva para la producción y comprensión de mensajes (afasia).

a. En la **primera fase**
- aparecen pérdidas ocasionales de vocabulario,
- dificultades para comprender ideas complejas,
- y disminución de las interacciones comunicativas

b. En la **Segunda fase**
-El vocabulario se empobrece.
-Dificultades frecuentes para encontrar la palabra adecuada.
-Pierden el hilo de la conversación..
-Utilizan palabras inventadas para referirse a objetos cuyo nombre no recuerdan.
-Ecolalia.
-Les resulta difícil construir frases con sentido.
-Mutismo.
-Postura corporal y gestos que no corresponden a los esperados.

c. En la **tercera fase**
-Disminución del lenguaje.
-Pérdida de iniciativa para comunicarse.
-Ecolalia.
-Comprensión muy mermada.
-Olvida la forma en como se articulan las palabras.
-Se limita a emitir quejidos, sonidos, gruñidos...

Estrategias de comunicación con personas con demencia:

- Eliminar las posibles fuentes de distracción (TV, radio...).
- Centre su atención y mírele a los ojos
- Utilice un lenguaje claro, sencillo, con frases cortas, evitando expresar más de una indicación en cada frase, y procurando no hablar en forma negativa sino positiva (es mejor decir "quédate aquí dentro" que "no salgas fuera".
- Realizar preguntas cerradas y dar tiempo para que la persona responda.
- No utilizar lenguaje infantilizado.
- Evitar el uso de pronombres (es mejor decir "tu hija va a venir" que "ella vendrá ahora").
- Llamarle por su nombre en todo momento para que la persona se oriente y le preste atención.
- Hablar en lenguaje literal, de forma concisa y no andarse por las ramas.
- En las fases más avanzadas, es primordial el contacto físico.

1.6. ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (ELA)

La **ELA** es una enfermedad degenerativa crónica del SNC que afecta a las neuronas motoras, disminuyendo su funcionamiento hasta su desaparición.

Esto produce una parálisis muscular progresiva, la pérdida gradual del control voluntario del movimiento.

La edad de inicio suele ser la edad adulta en torno a los 50 años (aunque se dan casos de inicio anteriores). La esperanza de vida iniciada la enfermedad suele variar (entre 1 y 10 años), teniendo mejor pronóstico cuando la edad de inicio es temprana.

Etiología o Factores que la causan:

Desconocidos, aunque parece que está determinada genéticamente, otras teorías señalan como posibles causas el mal funcionamiento del sistema inmunológico, exceso de toxinas y de sustancias químicas.

Síntomas característicos de la enfermedad:

Debilidad y pérdida de fuerza muscular, presencia de calambres, contracciones musculares. Estos síntomas afectan a la movilidad y realización de actividades cotidianas, así como al habla, la respiración, la masticación y la deglución . La enfermedad evoluciona en algunos casos con lentitud, produciendo progresivamente parálisis muscular.

No causa dolor, aunque la debilidad y los calambres musculares provocan molestias. No se ven afectados los movimientos del corazón, estómago, intestinos, ni las funciones intelectuales, los sentidos, los esfínteres ni la función sexual.

Características de la comunicación y del lenguaje:

- Conforme avanza la enfermedad los músculos bucofonadores pierden fuerza por lo que aparecen dificultades para articular las palabras y expulsar el aire.
- Voz gangosa, disartrias, disfonía, ritmo lento, dificultad para tragar (disfagia), excesiva salivación, todo ello influirá en la emisión de mensajes.
- La comunicación no verbal (gestos, expresión facial) también está comprometida, ya que la parálisis dificulta la expresión.
- En las fases finales de la enfermedad estas dificultades se agravan hasta el punto de hacer imposible la comunicación (anartria).
- Dificultades en la motivación para comunicarse.

Estrategias de comunicación:

Hablaremos más adelante sobre los sistemas técnicos y apoyos técnicos específicos en la comunicación con estas personas.

1.7. ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM)

La **EM** es una enfermedad degenerativa crónica del SNC en la que se da un endurecimiento de las partes de ese sistema, lo que interfiere en la transmisión de impulsos nerviosos. Se produce una inflamación del SNC. La mielina es una sustancia compuesta por proteínas y grasas que envuelve las fibras nerviosas y facilita la conducción del impulso nervioso entre las neuronas. En la EM existe una desmielinización que dificulta o interrumpe la comunicación interneuronal desde y hacia el cerebro. Esta enfermedad produce progresivamente pérdida de movilidad, fragilidad muscular y trastornos en el equilibrio, la coordinación de movimientos y la percepción de sensaciones.

La edad media de aparición está entre los 20 y los 40 años.

Etiología o Factores que la causan:

Son todavía desconocidos, parece que tanto factores genéticos como ambientales están implicados en la aparición de la enfermedad.

Síntomas característicos de la enfermedad:

Hormigueo, rigidez muscular, inestabilidad y falta de coordinación de movimientos, alteración de la sensibilidad, alteraciones visuales, trastornos del habla, problemas en el aparato genitourinario y trastornos cognitivos. Los síntomas entre unas personas y otras varían. Es más frecuente en mujeres.

Características de la comunicación y del lenguaje:

- Trastornos en la voz y el habla.
- La voz: pérdida de fuerza de los músculos implicados en la fonación, lo que causa alteraciones en el tono, timbre e intensidad de la voz.
- Voz gangosa.
- Disartria (dificultades en la articulación).
- Alteraciones de la velocidad (ritmo lento o muy rápido).
- Repetición de sílabas o palabras.
- Afasia o dificultad para producir y comprender mensajes.
- Deformaciones de las palabras.
- Cambios de unas palabras por otras.
- Circunloquios (rodeos de palabras para decir algo que se podía decir brevemente).

Estrategias de comunicación:

- Es necesario conocer y comprender bien sus dificultades comunicativas y de otro tipo que también interfieren en la comunicación: alteraciones sensoriales, físicas o cognitivas.
- Evitar el ruido ambiental (TV, radio,...), buscar espacios tranquilos.
- La persona que padece EM debe mantener una postura erguida, con el fin de que el habla se produzca mejor.
- No ejercer presión en el interlocutor para que las respuestas las conteste de prisa.
- Invitar a la persona a que tome aire antes de hablar y haga pausas durante la conversación.
- En los casos más graves puede ser necesaria la utilización de recursos como señalar, hacer gestos o escribir.
- Cuando la conversación se realice con una persona sentada (silla de ruedas...) hay que sentarse y comunicarse al mismo nivel de sus ojos.
- Cuando no se entiende a la persona con EM:
  - Hay que hacérselo saber.
  - Puede ser necesario pedirle que lo repita.
  - En ocasiones puede ayudar hacerle preguntas cerradas para aclararnos mejor: "¿Quieres decir...?"
  - Si después de todo seguimos sin comprender, hay que asegurarse de que se encuentra cómodo y de que no tiene ninguna necesidad básica y expresarle que aunque ahora no consigue entenderle, seguro que más tarde lo logran.

- Cuando la persona con EM presenta dificultades para comprender y recordar información compleja:
  - Es preciso darle por escrito la información y las instrucciones.
  - Las instrucciones deben ser claras, coherentes y secuenciales.
  - Habitualmente será necesario acompañar las instrucciones verbales con demostraciones visuales.
- Cuando la persona presente disartria:
  - Animar a la persona a hablar más lentamente y sin exagerar los sonidos. Darle el tiempo necesario para que pueda expresarse tranquilamente.
  - Para facilitar la comprensión, a veces se hace necesario mantener una comunicación no verbal invitándole a utilizar gestos y expresiones faciales.
  - Pedirle que rehaga las frases, esta vez más cortas.
  - Recordar en todo momento la importancia de la respiración en el proceso de producción del lenguaje.

1.8. DEFICIENCIAS AUDITIVAS

La discapacidad auditiva es la pérdida o el trastorno en la capacidad de audición.

En la capacidad auditiva intervienen: el sistema auditivo de la persona, la intensidad y la frecuencia de los estímulos, las variables del individuo (motivación, atención, cansancio..) y las variables ambientales.

La **discapacidad auditiva se clasifica según el grado de pérdida** en:

Hipoacusia leve	Pérdida de 20 a 40 dB
Hipoacusia moderada o media	Pérdida entre 40 y 70 dB
Hipoacusia severa	Pérdida entre 70 y 90 dB
Hipoacusia profunda	Pérdida superior a 90 dB
Cofosis	Sordera total. Muy pocos casos

En los dos primeros casos la audición es deficiente, pero permite el aprendizaje del lenguaje oral. Cuando las pérdidas son mayores el lenguaje oral presenta más dificultades.

Según el momento de aparición de la sordera se denominan hipoacusias prelocutivas (si son anteriores a la adquisición del lenguaje) o poslocutivas (si aparece después de tener adquirido el lenguaje oral, tienen mejor pronóstico).

Etiología o Factores que la causan:

Puede ser genética o adquirida:

a) Genética: de carácter hereditario, el 50% de los casos es de este tipo
b) Adquirida: por causas neonatales (en el momento del nacimiento o primeras horas de vida) y posnatales (otitis, tumores, fracturas de oído..)

Características de la comunicación y del lenguaje:

- Presentan dificultades para captar la información auditiva (palabras, tono, volumen, ritmo...). Sí captan señales no verbales (gestos, posturas, expresiones faciales...)
- Suelen presentar problemas en la articulación de los fonemas (no pronuncian correctamente porque han tenido dificultad para imitar los sonidos).
- Deficiencias en la estructura de la conversación por desconocimiento de las convenciones sociales.
- Dificultades con los tiempos verbales
- Su lenguaje es más literal, concreto. Existen menos términos referidos a conceptos abstractos.

- Los gestos, las miradas las expresiones faciales son muy importantes (en la lengua de signos resultan fundamentales) por ello el lenguaje no verbal es más rico que el de las personas oyentes.
- Las dificultades auditivas (según el grado de pérdida) pueden derivar en el aislamiento de la persona.
- En función de la pérdida, pueden utilizar dispositivos para amplificar el sonido o bien sistemas de comunicación Alternativos (p. ej:Lengua de signos) o aumentativos.

1.9. DEFICIENCIAS VISUALES

La discapacidad visual es la carencia o disminución importante de la capacidad de visión.

Para valorar la capacidad visual de una persona hay que considerar la **agudeza visual** (es la capacidad para distinguir formas, figuras y detalles de un objeto) y el **campo visual** (es la amplitud que se abarca con la vista a partir de un punto).

Etiología o Factores que la causan:

Las causas pueden ser genéticas o adquiridas

a) genéticas: transmitidas de padres a hijos (por ejemplo el glaucoma, el albinismo, la miopía degenerativa...)
b) adquiridas: aquellas que no son genéticas o hereditarias, por ejemplo la retinopatía diabética (ocasionada por la diabetes) o neurosis óptica (inflamación del nervio óptico).

Tipos de deficiencias visuales

Las deficiencias visuales se clasifican en función de la funcionalidad de la visión en

Ceguera total	Ausencia total de visión o sólo percepción de la luz
Ceguera parcial	Poseen restos visuales que permiten la percepción de bultos y de algunos matices de color
Ambliope profundo	Los restos visuales son mejores, los volúmenes están mejor definidos, se perciben los colores
Ambliope propiamente dicho	Precisa una buena iluminación o una presentación contrastada de los objetos

Características de la comunicación y del lenguaje:

- No presentan dificultades para el desarrollo del lenguaje oral ni alteraciones lingüísticas.
- Presentan problemas con toda la información No verbal (gestos, expresiones, miradas, postura corporal) lo que repercutirá a la hora de recibir e interpretar los mensajes.

El lenguaje permite a las personas con discapacidad visual compensar la ausencia de estímulos sensoriales visuales.

Puede que algunas personas con déficit visual tiendan al aislamiento social, el auxiliar tendrá que tener en cuenta sus dificultades con el fin de adaptar sus intervenciones para conseguir una comunicación más eficaz.

1.10. SORDOCEGUERA

La sordoceguera es una discapacidad multisensorial que impide o limita a la persona la capacidad de oír y de ver. No implica necesariamente la pérdida total de los dos sentidos, muchas de las personas con sordoceguera tienen resto auditivo o visual.

Etiología o Factores que la causan:

Las causas pueden ser las mismas que para la pérdida de visión o de audición; pero el síndrome de Usher o una medicación ortotóxica puede influir en la aparición de la discapacidad multisensorial.

Según la afectación, se clasifica en:

Total o congénita	Personas que se han quedado sordociegas antes de la adquisición del lenguaje
Sordera congénita	Personas que nacen con problemas de audición pero que pierden la vista. La causa principal suele ser el síndrome de Usher (enfermedad degenerativa heredada)
Ceguera congénita	Personas que nacen con problemas de visión y pierden la audición con el paso del tiempo o a causa de la medicación (ortotóxicos)
Sordoceguera postsimbólica tardía	Personas que se han quedado ciegas después de la adquisición del lenguaje.

Características de la comunicación y del lenguaje:

- En el caso de las sorderas congénitas se suele utilizar el lenguaje de signos con apoyo táctil.
- En los casos de ceguera congénita y sordoceguera postsimbólica tardía se utiliza el lenguaje oral y se recibe la información a través de la lengua de signos con apoyo táctil o sistema Braille.
- El caso de sordoceguera total, en el que no ha habido lenguaje simbólico de ningún tipo, es el más complejo. Se utilizan signos manuales con apoyo táctil básicos y concretos, es difícil alcanzar la L.S (lengua de signos)
- Las personas con sordoceguera presentan problemas graves de interacción y comunicación.
- Estas personas perciben poca información sobre dónde está, quién es, ..lo que conlleva numerosas dificultades de relación y tienden al aislamiento.
- El auxiliar debe conocer el grado de afectación y proveer de oportunidades de relación y de integración en el entorno.

1.11. CONSIDERACIÓN POR LA SITUACIÓN ESPECÍFICA DE CADA PERSONA CON PROBLEMAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

El auxiliar de apoyo domiciliario puede encontrarse con personas afectadas con alguno de las deficiencias estudiadas en este tema, por ello es fundamental que conozca los trastornos que posee la persona a la que va a atender, y sepa cómo van a influir en su forma de interactuar con los demás para poder adaptarse a la situación.

A pesar de ello, para poderse comunicar efectivamente, el emisor deberá adecuarse a las competencias lingüísticas y comunicativas que mantenga el interlocutor, advertir los problemas motores y/o articulatorios, además de tener en cuenta el contexto en el que se desarrolle el proceso (iluminación, ruidos ambientales...)

Vamos a concretar algunas estrategias para que el cuidador pueda aplicar en su relación con las personas que presentan dificultades en el lenguaje teniendo en cuenta por un lado las personas que tienen problemas en la RECEPCIÓN del mensaje y aquellos que presentan problemas en la COMPRENSIÓN O ELABORACIÓN de mensajes.

La habilidad de ELABORACIÓN del mensaje hace referencia a lo que se quiere expresar y cómo lo quiere expresar, para lo que son necesarias unas bases lingüísticas que le permitan construir un mensaje oral coherente y comprensible.

La capacidad de COMPRENSIÓN se refiere a las dificultades para entender el significado de las frases que percibe y por lo tanto no puede dar una respuesta.

a) **DIFICULTADES EN LA RECEPCIÓN DEL MENSAJE: personas ciegas o con déficit visual profundo, personas sordas o con déficit auditivo, personas con sordoceguera**.

- **Personas ciegas o con déficit visual profundo**

- poseen habla con normalidad.
- carecen de apoyos visuales que regulan la conversación (miradas, sonrisas, expresiones faciales..)
- Antes de dirigirnos a ellos llamaremos su atención para que perciban que nos dirigimos a ellos, nos acercaremos e incluso les tocaremos y les informaremos de quiénes somos.
- Cuando demos por finalizada la conversación les avisaremos verbalmente.

- **Personas sordas o con déficit auditivo**

- Evitaremos hablarles cuando estemos de espaldas o no puedan mirarnos porque están realizando otras tareas.
- Llamaremos su atención tocándoles en el hombro o en el brazo antes de hablarles.
- Es importante hablar despacio y bien
- No llevar objetos en la boca que dificulten la lectura de labios (piercing , bolígrafos, chicles...)
- No gritar
- Utilizar frases cortas y concretas, fáciles de entender
- Aunque lleve audífono no oye, por lo que tendremos en cuentas estas consideraciones al dirigirnos a él.
- Conocer algunas frases sencillas en Lengua de Signos (LS)

- **Personas con sordoceguera**

- Normalmente utilizaremos el LS con apoyo táctil ("escucha " colocando las manos sobre la persona que signa).
- Utilizaremos el alfabeto dactilológico sobre la palma de la mano.

- **Personas con trastornos en el habla**

- Darles seguridad para que utilicen el habla en sus intervenciones.
- Situarnos frente a ellas para poder ver su expresión facial y el movimiento de sus labios.
- Favorecer la comunicación asintiendo con la cabeza, con la mirada.
- Dejar tiempo suficiente para que puedan construir sus mensajes sin anticiparnos a lo que nos van a decir, sin adivinar lo que nos quieren decir.

Algunos usuarios utilizarán SAAC (sistemas aumentativos y alternativos de comunicación) como tableros de comunicación, comunicadores con voz digitalizada... el profesional deberá familiarizarse con el soporte y los símbolos que en él aparecen, dejaremos tiempo para elaborar los mensajes.

b) **Con personas con DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN O ELABORACIÓN DE MENSAJES**:

Personas con Alzheimer, demencias, discapacidad intelectual, con autismo.

- Utilizaremos frases y preguntas claras y cortas con sentido completo.
- Emplearemos la comunicación No verbal (gestos y expresiones faciales acordes con el mensaje oral)
- Es importante dejar un tiempo para que puedan procesar la información y responder.

2. LA COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS DEPENDIENTES

2.1. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN

En el apoyo domiciliario es imprescindible resaltar la importancia de la comunicación porque con ello evitaremos el aislamiento de la persona con dependencia.

La comunicación hace referencia al intercambio de información, a las actitudes, ideas, emociones, a través del contacto verbal o no verbal entre dos o más personas.

Es importante conocer cómo funciona el proceso de la comunicación para mejorarlo y resolver las dificultades que puedan surgir entre el auxiliar y el usuario al que presta su apoyo.

2.1.1. ELEMENTOS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN

En el proceso de la comunicación intervienen los siguientes **elementos**:

- **EMISOR**: la persona que expresa un mensaje (una información, un gesto, una expresión facial, una postura...). Las características propias del emisor van a condicionar la forma de establecer la comunicación (estado emocional, situación física, cognitiva).

- **RECEPTOR**: la persona que recibe el mensaje.

En la comunicación los papeles de emisor y receptor se intercambian

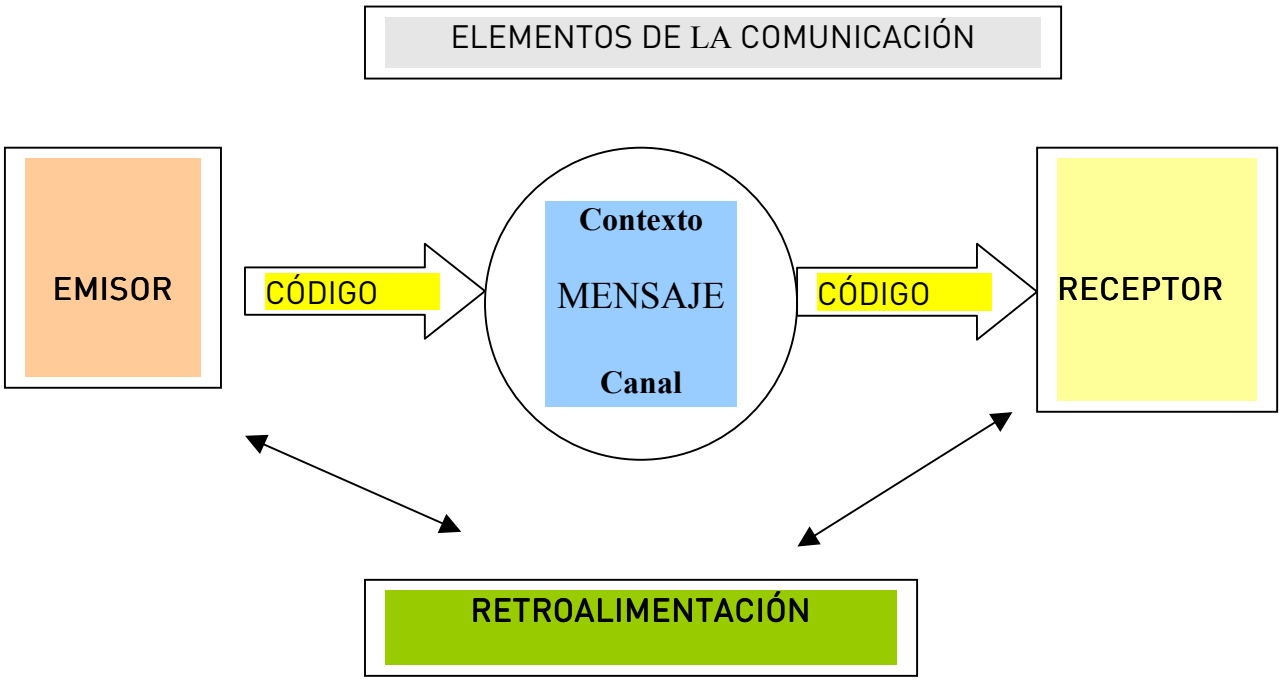
- **RETROALIMENTACIÓN** O FEEDBCAK: es el elemento que nos permite saber si la información ha sido recibida por el receptor, si se ha comprendido el mensaje, o si necesitamos repetir la información, o expresarnos de otra forma. En la comunicación con personas dependientes es muy importante saber si el mensaje está siendo comprendido. Hay que tener en cuenta las características de la persona, su expresión verbal y gestual.

- **CÓDIGO**: es el conjunto de elementos y reglas que dan forma al mensaje, puede ser auditivo, visual. Los idiomas son diferentes códigos de comunicación. Para que la comunicación sea posible los participantes tienen que conocer y compartir el código en el que se transmite el mensaje. El código no se limita a la lengua utilizada, podemos emplear gestos, caricias, signos....

- **MENSAJE**: Es el contenido de la información. Puede ser expresado fundamentalmente de dos modos: mediante lenguaje o gestos. De modo que la comunicación puede ser verbal o no verbal.

- **CANAL**: el medio, la estructura material a través de la cual se emite, transmite y recibe el mensaje. Los más frecuentes son el oral-auditivo y el gráfico-visual (escritura, símbolos...) utilizando el aire como medio, pero también utilizamos otros medios como el teléfono, el correo electrónico, el correo postal..

- **CONTEXTO**: momento en el que se desarrolla la comunicación, depende además de las características personales del usuario.



2.1.2. LENGUAJE NO VERBAL

En cuanto a la **comunicación NO VERBAL** es el conjunto de gestos, expresiones faciales , posturas, sonrisas, miradas...que acompañan al mensaje oral.

Como hemos dicho anteriormente, la comunicación (verbal y no verbal) es el proceso que se da entre dos o más personas por el que se produce un intercambio de información, ideas, sentimientos u opiniones. Gran parte del proceso de comunicación se realiza de forma **NO VERBAL** (gestos, postura corporal, miradas, silencios..) siendo ésta de suma importancia.
Por ejemplo un residente que prueba la comida y nos dice " Está buena" pero a la vez hace un gesto de desagrado, los dos mensajes son contradictorios, y en este caso creeremos el mensaje No verbal : la comida no le gusta.

El Lenguaje no verbal refuerza al verbal, acompaña al habla de la siguiente forma:

- **Repitiendo**: el gesto repite lo que se dice con la palabra. Por ejemplo digo NO y realiza el gesto de negación con la cabeza.
- **Contradiciendo**: el gesto contradice lo que se dice. La persona está llorando y dice que no le pasa nada.
- **Sustituyendo**: el gesto sustituye lo que se dice, por ejemplo afirmar con la cabeza.
- **Reforzando**: el gesto refuerza lo que dice " me duele el brazo " a la vez que señala donde le duele.
- **Regulando**: el gesto sirve de regulador de la conversación, asintiendo, realizando gestos con la cabeza, con las manos...de forma que se establecen los turnos de la conversación.

En el trabajo con personas con dependencia la comunicación No verbal es muy importante,. Por ejemplo, personas con déficit auditivo o cognitivo pueden tener dificultades para entender los mensajes verbales por lo que será imprescindible utilizar elementos no verbales para apoyarlo.

Factores que intervienen en la comunicación no verbal

Las técnicas de comunicación no verbal que el profesional de atención sociosanitaria utiliza se relacionan con factores cinestésicos (postura, mirada, expresiones faciales, y gestos), factores proxémicos (distancia personal) y factores paralingüísticos.

A. Factores cinestésicos:

- La **postura** más adecuada para mostrar predisposición a la comunicación es una postura relajada, un poco inclinada hacia la persona a la que nos dirigimos. Por el contrario una postura tensa, con brazos cruzados indican deseos de mantener las distancias. Dirigir el cuerpo hacia atrás o hacia otro lado de la persona, son indicadores de desinterés. Demasiados movimientos pueden distraer, mientras que excesiva rigidez indica un exceso de formalidad.

- **La mirada** nos ayuda a implicar a la persona en el proceso comunicativo. Con las personas con déficit visual emplearemos estrategias como tocar el hombro, la mano, el brazo, y lenguaje verbal. La mirada debe ser directa y cordial. Evitaremos dirigir la mirada hacia otros lados y parpadear en exceso (denotan deseos de estar en otra parte, incomodidad, ansiedad). También debemos cuidar la intensidad, porque mirar fijamente y sin interrupciones pueden hacerle sentir incómoda, invadida; por el contrario mirarla muy poco puede ser interpretado como falta de atención, falta de interés. La frecuencia de la mirada será mayor cuando se hable de temas generales, sin embargo al tratar temas íntimos o cuando las personas son tímidas, la frecuencia disminuye.



- En cuanto a las **expresiones faciales**, el repertorio es muy amplio. Algunas personas son muy expresivas y de forma natural enfatizan los movimientos de la cara. La expresión facial es difícil de controlar, además no todos los movimientos se realizan de forma consciente. Por ejemplo un profesional que camina abstraído, pensando en algo que le preocupa, puede mostrar el ceño fruncido, rostro tenso…lo que alguien que no la conozca puede pensar que es una persona huraña.

En la relación con las personas dependientes es importante ser consciente de las expresiones que se muestran y ver que sean coherentes con el mensaje que deseamos transmitir. Por ello para indicar buena predisposición hacia el usuario mostraremos un rostro relajado; para demostrar enfado: mirada dura y directa, ceño fruncido, para indicar sorpresa: ojos muy abiertos, cejas arqueadas y boca abierta sin tensión.

- La expresión facial más utilizada en las relaciones interpersonales es **la sonrisa** que favorece el acercamiento y alivia las tensiones.

- **Los gestos** que realizamos con las manos, con la cabeza y con los pies pueden ayudar a aclarar la expresión verbal. Para favorecer el acercamiento a los usuarios hay que controlar la gesticulación, ya que si es excesiva puede incomodar. Hay que tener en cuenta que apuntar a la otra persona con el dedo es un gesto que puede resultar muy agresivo.

- **El tacto** es importante para conectar con el usuario, coger de la mano, tocar el hombro, abrazar. Debemos ser prudentes y respetuosos ya que algunas personas pueden interpretarlo como una insinuación sexual, o una invasión de su espacio. Como ya hemos indicado antes tocar es una forma para llamar la atención de las personas con déficit visual.

B. **Factores Proxémicos**:

La **distancia interpersonal:** Para dirigirnos a la persona dependiente de forma individual utilizaremos la distancia personal (entre 50 y 120 cm), si la comunicación es entre varias personas a la vez, emplearemos la distancia social (120cm a 360cm) y la pública si nos dirigimos a grupos numerosos (más de 360 cm). Pero hay tareas profesionales (aseos, transferencias, movilizaciones ...) que requieren mucha proximidad física. Esta proximidad también la emplearemos en las expresiones de apoyo y afecto.

C. **Aspectos Paralingüísticos**:

El **volumen** de voz, la **entonación**, el **ritmo** y la **fluidez** con que sea emitido el mensaje.

Es fundamental tener claro lo que se desea transmitir y hacerlo de forma sencilla y breve.

A modo de resumen, las técnicas básicas de comunicación no verbal se basan en la correcta emisión de signos y gestos con una función comunicativa, expresiva y complementaria al lenguaje verbal. El profesional de atención domiciliaria ha de conocer cuál es la postura corporal adecuada para transmitir un mensaje correctamente, así como controlar las expresiones faciales y corporales para mantener la atención del receptor y transmitirle la información de forma clara y directa, sin barreras comunicativas.

2.2. NECESIDADES ESPECIALES DE COMUNICACIÓN

Las personas en situación de dependencia pueden presentar **Necesidades Especiales de Comunicación (NEC)**: dificultades para la comunicación, ya sea por la existencia de trastornos en la comprensión o en la expresión del mensaje, ya sea por déficits físicos, sensoriales o cognitivos. Es por ello que se hace necesario adecuar un sistema de comunicación más idóneo y adaptado a las peculiaridades de cada uno.

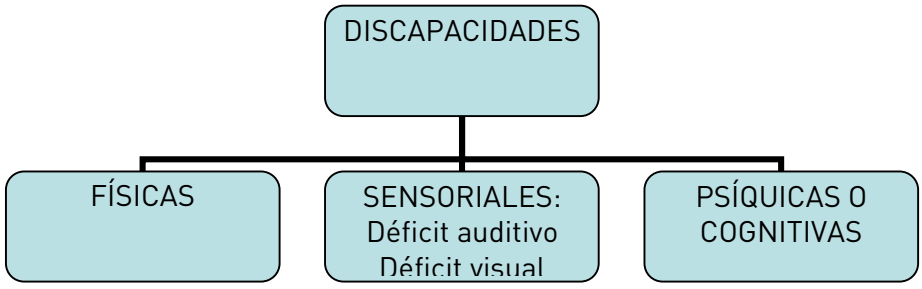
Las dificultades para la comunicación pueden ser **temporales**: Duran un periodo determinado, en función de cómo evoluciona la persona. Suelen estar causadas por traumatismo, lesión, intervención quirúrgica, tumores, accidentes cerebro vasculares. En todos estos casos hay una lesión que afecta a los órganos de fonación (boca, faringe...) y que provoca que la persona tenga problemas en la comunicación. El problema se suele resolver con tratamiento logopédico, una nueva intervención o la extirpación del tumor.

Por otro lado, las dificultades para la comunicación también pueden ser **permanentes**: como las que se derivan de un déficit congénito (P.C.) o aquellas que surgen a partir de una enfermedad neurológica como el Alzheimer, Parkinson, EM... El origen es mucho más variado: causas genéticas, enfermedades degenerativas, enfermedades orgánicas, patologías adquiridas o enfermedades sensoriales. En todos los casos de NEC las personas deben ser atendidas por equipos multidisciplinares que valorarán la rehabilitación que cada uno necesite.

Las NEC pueden ser muy diversas, resulta esencial conocerlas con el fin de adaptar nuestra comunicación a ellas.

Es importante que el auxiliar domiciliario conozca las habilidades y las NEC de los usuarios con los que va a trabajar, para poder aplicar las estrategias y los recursos más adecuados permitiendo una comunicación lo más productiva y eficaz posible.

2.3. DISCAPACIDADES



La clasificación de las discapacidades se divide en 3 grandes grupos en función de las áreas afectadas : discapacidad física, discapacidad sensorial y discapacidad psíquica.

La discapacidad puede causar dificultades de comunicación y de relación con otras personas (a veces tienden a aislarse). Por ejemplo, una persona con discapacidad visual puede tener dificultades de comunicación al no captar toda la información sensorial (no sabe todo lo que están sucediendo a su alrededor). Una persona con discapacidad física puede ver disminuidas sus interacciones con otras personas a causa de sus problemas de movilidad.

ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON NEC

1.DISCAPACIDAD FÍSICA / estrategias de intervención

En principio todas las personas con discapacidad física NO presentan NEC, pero a veces aparecen otros trastornos asociados como Parálisis Cerebral, Parkinson, Esclerosis Múltiple, ELA... que sí afectan al habla. Estrategias:

- Tener paciencia ante sus intervenciones.
- No adelantarse a lo que quieren decir.
- Preguntar cuando no entendemos.
- Devolverles feed-back de lo que hemos entendido (asintiendo con la cabeza y la mirada).
- Asegurar el mensaje.
- Hablarle vocalizando bien y con mensajes claros.
- Aprovechar la expresión corporal, sin exagerar.
- Estar atentos a sus indicaciones y sonidos.
- No olvidarnos de que nos oyen.

2.DISCAPACIDAD VISUAL / estrategias de intervención

No poseen el apoyo de los elementos no verbales de la comunicación (gestos, sonrisas, miradas).

- Centrar la atención en la persona más que en su discapacidad, ya que ésta es sólo una característica más.
- Antes de dirigirnos a ella, tenemos que llamar su atención, para que perciba que nos vamos a dirigir a ella, para ello haremos uso del contacto físico
- Informarle de quienes somos. y dirigirnos a ella directamente.
- Preguntar antes de ayudarle si quiere que lo hagamos
- No utilizar indicativos verbales (ahí, allí), sino terminología que facilite la orientación espacial: "está a la derecha de la puerta".
- Utilizar con naturalidad palabras como : "ver", "mirar", "ciego", "ceguera"

- Cerciorarnos de que la iluminación es la adecuada, de modo que la persona pueda captar determinados gestos con su capacidad visual residual (si la tuviera).
- Avisar a la persona cuando nos vamos,
- Comunicarle si hay más personas o cuando se ausentan .
- Es preciso comunicar qué se está haciendo o se va a hacer.
- No sustituir el lenguaje oral por gestos.
- Dirigirse directamente a la persona cuando le estamos hablando.
- No aumentar el tono de voz, ni vocalizar de manera especial.
- Dar solamente las indicaciones necesarias.

3.DISCAPACIDAD AUDITIVA / estrategias de intervención

La comunicación No verbal (gestos, expresión facial...) es muy importante.

- **Para llamar la atención o comenzar la comunicación:**
  - tocar en el hombro o el brazo suavemente (nunca en pecho, espalda o cabeza).
  - Tocar en el muslo si se está sentado
  - Agarrar la mano
  - Golpear el suelo, mesa..etc
  - Mover el brazo si estamos lejos
  - Apagar y encender las luces

- **Para introducirse en la conversación**
  - Se toca el brazo de la persona con la que se quiere hablar y se pide perdón a la otra persona. Cuando se termina de dar el mensaje, se da las gracias y se va.
  - Se introduce la conversación indicando el tema sobre el que se va a hablar.

- **Asegurar la comunicación**
  - En la Cultura Sorda, es muy frecuente que cada cierto tiempo se emplee el signo : "¿comprendes?" para obtener retroalimentación.
  - Utilizar signos conativos para indicar que se está entendiendo lo que se dice. (si, razón, es verdad).
  - Ser natural.
  - Colocarnos frente a él/ella para conversar, ya que necesita ver los labios para completar la información residual auditiva.
  - Modular la voz y la articulación con naturalidad, vocalizar sin exagerar para no deformar las palabras y que pierdan el significado. No es preciso alzar exageradamente el tono de voz, a no ser que la persona lo solicite.
  - Averiguar si la persona sabe leer, esto podría facilitar mucho la comunicación.
  - Repetir el mensaje si fuera necesario.

- Nunca volver la cabeza hacia otro lado, ya que indica desinterés.
- Nunca agarrar las manos de una persona que está signando ya que puede equipararse a tapar la boca a alguien que está hablando.
- No debemos olvidarnos de que una persona sorda, a pesar de llevar una prótesis auditiva, nunca oirá de la misma forma que un oyente.
- Debemos asegurarnos de que no estamos a contraluz.
- No seguir hablando de espaldas a la personas sorda.
- No hablar demasiado deprisa pero tampoco demasiado despacio.
- A ser posible evitar bigote, pelo sobre el rostro y chicles, caramelos, cigarros, bolis cerca de la cara, ya que dificulta la lectura labial.
- Debemos asegurarnos de estar a una distancia no superior a 2,5 metros, para facilitar la labio-lectura.
- No abusar de la lectura labial, ya que resulta muy fatigoso durante períodos largos.
- No utilizar palabras demasiado complejas ya que no las reconocen fácilmente.
- No engañarle diciéndole que se le entiende si no es así, la persona se dará cuenta.
- Realizar frases cortas y sencillas pero gramaticalmente correctas.
- Utilizar toda clase de recursos expresivos y visuales al alcance de nuestras manos.
- No exagerar los gestos, hacerlos de forma sencilla y natural.
- A una persona sorda le resulta imposible atender a dos canales visuales de comunicación de forma simultánea (leer un prospecto y atender al emisor).
- Debemos ser pacientes.
- Si se encuentra entre varios interlocutores oyentes, evitar que se sienta aislada explicándole lo que se está hablando con claridad.
- Compartir la información: la privacidad y la confidencialidad es algo difícil de conseguir en la Comunidad Sorda, ya que generalmente sus conversaciones son visibles, por ello los rumores se propagan con facilidad.
- Adiós: marcharse dentro de la Comunidad Sorda es bastante costoso y suele alargarse en el tiempo. En cualquier caso, es un protocolo habitual en este colectivo. Cuando las personas sordas terminan una conversación, suelen explicar a dónde van y qué van a hacer. Marcharse con demasiada rapidez o sin despedirse puede ser malinterpretado.
- En los comedores: se suelen situar bajo focos de luz y en mesas preferiblemente redondas o dispuestas en forma de “u”. Suelen tardar bastante en comer ya que lo simultanean con la acción de signar.

3.SORDOCEGUERA / estrategias de intervención

- Buena iluminación y reducción del ruido ambiente.
- Uso de colores contrastantes y señalización táctil.
- Utilización de lenguaje más lento y básico.
- Aprovechar todos los restos auditivos y visuales.

2.4. SALUD MENTAL

Algunos de los usuarios de atención domiciliaria pueden tener problemas de salud mental. Tradicionalmente la enfermedad mental ha sido muy poco comprendida considerándose en muchos casos, signo de debilidad de carácter o actitudes caprichosas de la persona afectada.

Las causas de los trastornos mentales son muy diversas, aunque en la mayoría de los casos se trata de una combinación de factores biológicos y ambientales.

El listado de enfermedades mentales que recogen los manuales de psiquiatría es muy amplio, pero vamos a explicar estrategias de comunicación con los casos que nos podemos encontrar con más frecuencia en la ayuda a domicilio: Esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y ansiedad.

2.4.1. ESQUIZOFRENIA

Su característica principal es la pérdida total de contacto con la realidad. Este trastorno se caracteriza por alteraciones del pensamiento y de la percepción (delirios, alucinaciones, ilusiones), cambios emocionales y dificultad en la relación con los demás.

La **comunicación** se ve muy afectada, el lenguaje se deteriora ya que las alucinaciones y los delirios están muy presentes, por lo que los mensajes resultan incoherentes y difíciles de comprender, lenguaje disgregado y sintaxis pobre y alteraciones semánticas. Resulta muy dificultosa la comunicación coherente y eficaz.

Características de la comunicación y del lenguaje:

- El habla es poco fluida y confusa.
- No muestran interés por su interlocutor.
- Presentan dificultades para mantener la atención.
- Emplean un volumen bajo y una entonación monótona.
- Algunos hablan muy lento y otros por el contrario muy deprisa.
- No emplean el lenguaje No verbal para apoyar los mensajes (escasa expresividad, mirada huidiza, cercanía invasiva o excesiva).
- Lenguaje ininteligible, incoherente y/o difícil de comprender por el interlocutor.

Estrategias para la comunicación:

- Expresar las ideas de forma simple y breve.
- Mantener el contacto visual.
- Procurar un ambiente libre de distracciones.
- Repetir la idea que queremos transmitir.
- Asegurarse que se ha entendido el mensaje (que el usuario lo repita)
- Utilizar el lenguaje No verbal de forma adecuada.
- Ante una conversación delirante o inconexa, mostrar nuestro desacuerdo con delicadeza, pero no debemos llevarle la corriente.
- Desviar la atención hacia otros temas, cambiando de habitación, haciendo que se fije en otras cosas que suceden a su alrededor.
- En momentos de crisis, mantener la calma, no gritar ni enfadarnos y evitar gestos que puedan ser interpretados como una agresión (mirada fija, contacto físico...).

2.4.2. TRASTORNO BIPOLAR

Se manifiesta por cambios bruscos de ánimo, pasando de un estado de depresión a un estado de ánimo anormalmente alto (manía).
La fase de depresión se caracteriza por una tristeza intensa, cambios de apetito y de sueño, cansancio, apatía, culpabilidad, autoestima muy baja y pérdida de la libido (deseo sexual).
Por otro lado, **la fase de manía** se caracteriza por estado de euforia, falta de concentración, pensamiento acelerado, aumento del habla, insomnio, hiperactividad, conducta agresiva o provocativa y aumento de la libido.

La etiología (su causa) es desconocida, la edad de aparición entre los 15 y los 25 años. El tratamiento combina farmacología y apoyo psicológico. Presentan dificultades graves en las relaciones sociales (familiar, personal y laboral).

Características de la comunicación y del lenguaje:

La comunicación varía en función de la fase donde se encuentre.
En la fase depresiva: Presenta un marcado desinterés por la comunicación y las relaciones sociales.
En la fase de euforia / manía: Aumento del habla, y gran aumento de energía. La comunicación aparece en forma de verborrea (lenguaje alborotado y continuo, rápido y confuso).

Estrategias para la comunicación:

- Ser consciente de estas características.
- Mantener la calma, dirigirse al usuario con tranquilidad.

- Fijarse unos límites de forma conjunta con la familia importantes ante las situaciones de crisis para evitar llegar a extremos difíciles de manejar.

2.4.3. DEPRESIÓN

Es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por sentimientos de tristeza intensa y apatía, durante un tiempo prolongado y que interfieren en las actividades cotidianas.

Entre los síntomas están: trastornos del sueño, trastornos del apetito, sentimiento de inutilidad y de culpa, falta de concentración, ansiedad, apatía, pensamientos recurrentes de suicidio y llanto incontrolable. Algunas personas pueden presentar alucinaciones, percepciones distorsionadas de la realidad o delirios. En los casos graves puede ser altamente invalidante.

Etiología: sucesos emocionalmente traumáticos, abuso de tóxicos, soledad, estrés continuado, aunque a veces no existen factores externos que la desencadenen. Es más frecuente en mujeres que en hombres.

Características de la comunicación y del lenguaje

- Muestran desinterés por comunicarse con los demás.
- Disminuyen la velocidad y el volumen del discurso.
- El discurso tiende a ser repetitivo debido a su falta de atención.
- El contenido del discurso es pesimista.
- Desinterés por realizar cualquier tipo de actividad.
- Expresan ideas negativas,
- Les resulta difícil explicar cómo se sienten,
- Creen que nadie les comprende y que no se les puede ayudar.

Estrategias para la comunicación

- El auxiliar debe comprender que la depresión es una verdadera enfermedad que no depende de la voluntad del afectado.
- Es importante evitar las críticas, los gritos y enfados.
- No debemos obligar a que deje la tristeza a un lado.
- Sí tenemos que mostrarnos a su lado (empatía), comprenderle, pero verbalizar que poco a poco esta situación pasará.

2.4.4. TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (TAG)

Se caracteriza por sentimientos de preocupación excesiva a las situaciones que la provocan, que no responde a la racionalización y que se mantiene al menos 6 meses. Puede ir acompañado de irritabilidad, dificultad para concentrarse , problemas de sueño, temblores, tensión muscular, fatiga, sequedad de la boca

y problemas gastrointestinales. Puede llegar a ser grave si interfiere en la realización de las actividades cotidianas.

Es más común entre las mujeres. Por lo general es un trastorno crónico, con etapas de mejoría y otras de empeoramiento que coincide con situaciones de mayor estrés. El tratamiento suele ser farmacológico y terapia psicológica.

Características:

- La comunicación suele ser normalizada, salvo en las formas severas que pueden aparecer dificultades de relación (excesiva preocupación en sus interacciones con los otros).
- Búsqueda continua de aprobación.
- Síntomas físicos, como náuseas, sudoración, temblores.

Pautas que debe seguir el auxiliar:

- Es importante recibir información sobre cómo afecta el trastorno al comportamiento del usuario (del responsable del SAD o de los familiares):
- Ayudar a generar un entorno estable, con regularidad y rutinas diarias.
- Mantener una actitud paciente y comprensiva, recordando que es una persona con un trastorno y que no lo hace por molestar.
- Ser discreto y evitar preguntas directas sobre el trastorno (pueden hacer sentirse mal al usuario).

2.5. MINORÍAS ÉTNICAS

Las minorías étnicas son grupos que comparten una cultura, unas tradiciones, una lengua y un origen, que tienen conciencia de su existencia como grupo y están en riesgo de ser subordinados a la mayoría dominante.

Características de la comunicación y del lenguaje

- Las dificultades de comunicación de las personas con dependencia procedentes de minorías pueden verse aumentadas por el desconocimiento del idioma, o de las diferencias culturales.
- Es preciso conocer que en el aprendizaje de una segunda lengua habitualmente está más afectada la expresión que la comprensión.
- En cuanto a la producción del lenguaje presentan dificultades de articulación por problemas de discriminación fonética y fonológica.

El auxiliar debe procurar la mejor atención al usuario independientemente de su procedencia étnica.

Estrategias para la comunicación

(NO son diferentes a las establecidas para con otros usuarios).

- Mantener una actitud abierta y flexible, dejando de lado los prejuicios que se puedan tener hacia ese grupo étnico.
- Incentivar la comunicación y minimizar la barrera cultural interesándose por conocer la cultura del usuario.
- Acercarse siempre con respeto y evitar discutir: no tratar de imponer ideas propias.
- Escuchar y observar atentamente, lo cual nos puede ayudar a comprender mejor el modo de comunicación del usuario.
- Utilizar el lenguaje adecuadamente, vocalizando con claridad y empleando un volumen adecuado.
- En el caso de que no conozca nuestro idioma será necesario que alguien cercano (familiar o amigo) realice las funciones de intérprete.
- Cuidar el lenguaje No verbal (cuidar por lo tanto las expresiones faciales, gestos, posturas..).

2.6. OTROS

2.6.1. ALZHEIMER

Es uno de los trastornos que vamos a encontrar con mayor frecuencia en los domicilios. Se trata de un tipo de demencia, por lo que las pautas y estrategias de comunicación que vamos a señalar pueden utilizarse con personas afectadas por otras demencias.

Estrategias para la comunicación

- Establecer contacto visual, si es posible a la misma altura antes de dirigirnos a ellos, si tiene déficit visual le tocaremos el hombro.
- Utilizar frases sencillas y concretas, dado la información de forma directa, les daremos las informaciones de una en una.
- Vocalizar y usar un volumen de voz adecuado, no es necesario hablar alto, no poseen déficit auditivo.
- Transmitir calma, son muy sensibles a los estados de ánimo y las señales no verbales.
- Hablar en positivo, no poner énfasis en lo que no puede hacer (utilizar frases con "haz", en lugar de "no hagas...").
- Repetir su nombre con frecuencia, lo que le ayuda a captar la atención y lo mantiene orientado a nivel personal.
- Apoyar la comunicación verbal con refuerzos visuales (ej. señalar el plato cuando le decimos " vamos a comer")
- Evitar discusiones.
- Darle el tiempo suficiente para hacer las cosas.

- Utilizar formas de cortesía para reforzar lo que queremos obtener: "por favor, puedes hacer…", "gracias por hacer…."
- Nunca excluirle de la conversación.

Pautas para comprender lo que quiere expresar:

La persona con Alzheimer tendrá problemas para comprender los mensajes, pero también para expresar lo que desea.

- Si quiere un objeto, pero no se acuerda del nombre pedirle que lo señale con el dedo.
- Si utiliza una palabra por otra, repetir el mensaje con la palabra que entendemos que es y preguntarle si era eso lo que quería.
- Si se traba en la mitad de la frase, esperar, darle tiempo para que termine, si no consigue retomarla es mejor cambiar de tema.
- A veces es incapaz de explicar dónde le duele, o porqué llora o se siente nervioso, debemos intentar identificar qué es lo que le sucede.
- No debemos fingir que le hemos entendido si no es así.
- Otra técnica es formular preguntas de tipo sí o no para que pueda responderlas, o si tiene que elegir entre varias opciones limitarlas a un máximo de 2.
- Para mantener conversaciones , la norma es plantear preguntas generales o sobe actividades que esté realizando.

Respecto al ambiente,

Es importante procurar un ambiente tranquilo, sin ruidos o interferencias que puedan distraerle.
Si percibimos que se agita cuando hay mucha gente, les comentaremos a los familiares y amigos, para que se turnen en las visitas.

Respecto a la comunicación NO VERBAL

- Utilizar una expresión facial adecuada, es importante mantener la sonrisa, ya que facilita la comunicación.
- Apoyar el mensaje verbal con el lenguaje gestual adecuado.
- Importancia del TACTO, el contacto físico transmite cordialidad, cercanía, afecto, lo cual tranquiliza y aporta seguridad.
- Cuidar el tono de voz, a veces la persona no es capaz de entender las palabras, pero sí capta el tono del mensaje. Que una persona no sea capaz de entender no quiere decir que no se le deba hablar.

2.6.2. AUTISMO
Estrategias para comunicarnos

- Evitar el contacto físico, si no es necesario.
- Formular frases sencillas y claras.

- Dejar tiempo para que comprenda y elabore su respuesta.
- Evitar el uso de la ironía o frases con doble sentido (chistes.)
- Ser comprensivo ya que muchas veces estas personas no poseen habilidades para iniciar, mantener o finalizar conversaciones.

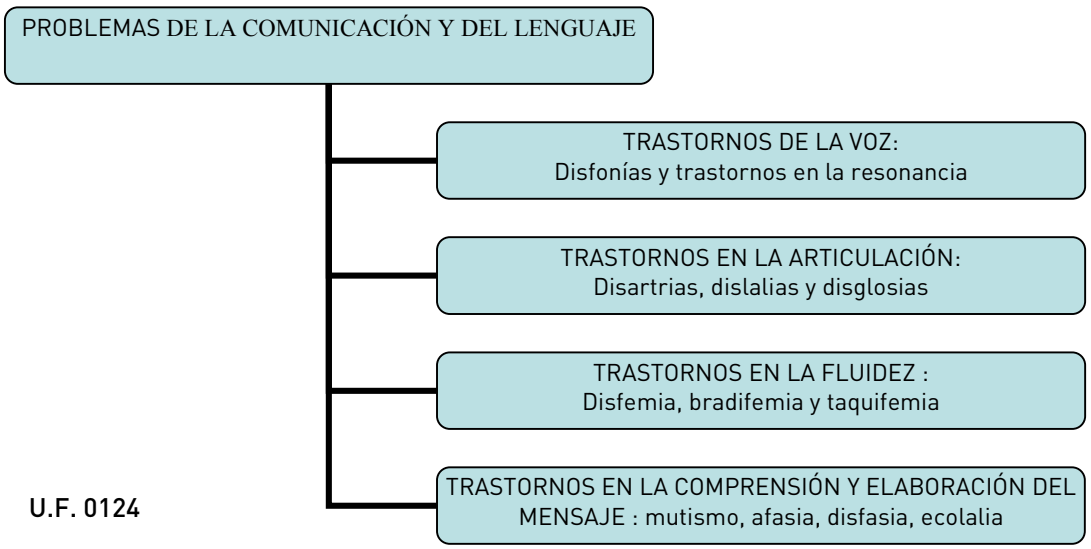
2.6.2. PERSONAS CON ENFERMEDAD CON DOLOR
Estrategias de comunicación

- En general se sienten decaídas y poco motivadas a establecer relaciones interpersonales.
- A veces el dolor puede causar irritabilidad, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación.
- Debemos mostrarnos pacientes.
- Con empatía: no podemos negarle el dolor, sino que tenemos que reconocer su sufrimiento sin dejarnos arrastrar por su angustia.
- Actitud tranquila, favoreciendo la expresión de sentimientos, estimulando su iniciativa por comunicarse.
- Proponer técnicas para minimizar el dolor (relajación, masajes..).
- Realizar actividades que sean de su interés (escuchar música, leer la prensa....)

2.6.3. PERSONAS CON ENFERMEDAD TERMINAL.
Estrategias de comunicación

- Mantener actitud tranquila y mostrar empatía reconociendo las preocupaciones del usuario sin negarlas.
- Actitud positiva pero sin dar falsas expectativas : No decir " te vas a poner bien".
- Preguntarle por sus temores, deseos o preocupaciones.
- Es importante acordar con la familia la información que vamos a dar al usuario sobre su estado.

2.7. PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE



Definiciones de los trastornos del lenguaje más frecuentes

DISFONÍA: Alteraciones del tono, timbre e intensidad de la voz.

DISLALIA: Dificultad para pronunciar correctamente determinados fonemas.

DISGLOSIA: Consecuencia de una malformación o lesión en los órganos del habla.

DISARTRIA: Se produce por lesiones en el SNC que afectan al control de los músculos implicados en el habla.

DISFEMIA: Trastorno de fluidez, alteraciones en el ritmo del mensaje hablado. Repeticiones.

DISFASIA: Pérdida parcial del lenguaje, se caracteriza por una reducción en el lenguaje habitual de la persona.

2.8. ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE INTERVENCIÓN COMUNICATIVA

2.8.1. CONSIDERACIONES BÁSICAS

1. Respetar la dignidad de la persona, el hecho de que presente dificultades para comunicarse verbalmente, no significa que tenga problemas cognitivos u otras habilidades.
2. Nunca debemos mostrar actitudes compasiva o sobre protectoras, que pueden afectar a la autoestima del usuario
3. No fingir que le entendemos si no es así, si aparentamos que le entendemos, le quitamos oportunidades de explicarse de nuevo perdiendo la posibilidad de entender lo que nos quiere decir.
4. Debemos dirigirnos a ellos conforme a la edad que tiene, no caer en el infantilismo.
5. Debemos emplear todos los recursos disponibles para mejorar la comunicación, valorando cualquier señal (miradas, gestos, sonidos..) ya que así el usuario intentará repetirlo logrando cada vez una comunicación más eficaz.

2.8.2. ESTRATEGIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

1.Elegir el lugar y el momento adecuado para hablar

- Nos sentaremos de frente o al lado, a la misma altura.
- En un lugar cómodo, de ambiente poco ruidoso y tranquilo.

2.**Escuchar atentamente utilizando un tono de voz amable**

- Mantener la calma, intentar sonreír y mostrar sentido del humor.
- La falta de paciencia sólo nos lleva a situaciones de conflicto.
- En situaciones tensas responder con tranquilidad.

3**. Mantener el contacto físico y visual. Preguntar y realizar peticiones de manera positiva**

- El apoyo, los mensajes de ánimo les hacen sentirse seguros, les evita el aislamiento y favorecen la autoestima.
- Es importante transmitir afecto, cogerles las manos cuando hablan, acariciarles, sonreírles.

4 **Dejar tiempo para responder**

- Si la persona se esfuerza por encontrar una palabra para comunicar un pensamiento trataremos de ayudarle diciéndole amablemente la palabra que está buscando.
- Tenemos que darle la oportunidad de responder, un largo silencio nos puede indicar que está intentando comprender lo que le hemos dicho y que busca un respuesta.
- Si no responde volveremos a realizar la pregunta.

2.8.3. TÉCNICAS GENERALES PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN

- **Hablar clara y pausadamente**: despacio y con buena vocalización.
- **Realizar las repeticiones pertinentes**: que nos quede claro que el paciente nos ha entendido.
- **Dar mensajes claros e inequívocos**: utilizando frases sencillas y cortas para no dar lugar a confusiones.
- **Realizar comentarios sobre los acontecimientos en curso**: sobre lo que está pasando a su alrededor. Explicarle lo que vamos haciendo con él. Esto facilitará su comprensión.
- **Usar experiencias antiguas**: como contacto con el presente, realizar reminiscencias.
- **Animar a la respuesta**: evitando siempre que se frustre.
- **Utilizar todos los sentidos**: facilitando la entrada de información.
- **Mantener el contacto ocular**: para obtener y mantener la atención.
- **Tener en cuenta la CNV**: ayudándonos del lenguaje corporal para hacernos entender.
- **No apremiar al paciente**: adaptar la comunicación a sus requerimientos.
- **Facilitar un clima de buen humor**: crea mayor confianza.
- **Adecuar nuestro tono de voz:** sobre todo ante la presencia de alteraciones auditivas. Tener cuidado para no perder.

2.9. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.

La incomunicación es uno de los problemas más grandes a los que se puede enfrentar una persona, sobre todo en el caso de los individuos que la sufren siendo conscientes de ello.

Por lo tanto vamos a aproximarnos a lo que entendemos por **sistemas alternativos de comunicación:** las distintas estrategias o ayudas puestas al servicio de las personas seriamente discapacitadas en el ámbito del lenguaje oral para establecer relaciones comunicativas.

Vamos a considerar algunos aspectos de los sistemas de comunicación:

- La utilidad de los sistemas consiste en favorecer la capacidad de expresión, por lo que cualquier posibilidad de lenguaje oral ha de ser explotada al máximo.
- Un sistema alternativo y complementario de comunicación no es como el lenguaje oral, pero no por ello se ha de considerar inútil su implantación, al contrario, a pesar de las limitaciones de cualquier sistema de comunicación en comparación con el habla, su uso acerca a las personas a las ventajas que el habla conlleva.
- Cuando se comienza a trabajar con un sistema, su uso no sustituye la intervención logopédica, ya que el trabajo con ambas es necesario para la adquisición del lenguaje.
- Una clara limitación es que se necesita el conocimiento del sistema por parte de las personas que quieren interactuar , y en ocasiones aprenderlo no es tan sencillo.

Es preciso clasificar los sistemas de comunicación según sean sistemas complementarios (aumentativos) a la comunicación, como es el caso de la comunicación bimodal, la palabra complementada o Cued-Speech, o sistemas alternativos a la comunicación, en el caso de que la persona no se pueda beneficiar del lenguaje oral, como el lenguaje de signos, SPC (Símbolos pictográficos para la comunicación) o Bliss.

Algunos de estos sistemas, para poder ser utilizados, precisan apoyos externos como un tablero de letras, palabras, imágenes o símbolos para la comunicación, como es el caso del SPC.

Definiciones

Todo sistema de comunicación que no utilice palabras articuladas pero que tenga suficiente nivel de estructuración convencionalizada para transmitir información. Es, pues, una comunicación lingüística sin que el emisor articule sonidos del habla (Puig de la Bellacasa, 1985).

Son instrumentos de intervención logopédica/educativa destinados a personas con alteraciones diversas de la comunicación y/o el lenguaje, y cuyo objetivo es la enseñanza mediante procedimientos específicos de instrucción, de un conjunto estructurado de códigos no vocales que permiten funciones de representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable) por sí solos o en conjunción con otros códigos, vocales o no vocales (J. Tamarit, 1993).

Sistemas alternativos

Van dirigidos hacia aquellas personas que no tienen lenguaje oral y que es imposible que se dé a corto o largo plazo, o que se considera que el esfuerzo necesario para que el lenguaje se dé no es rentable y se necesita encontrar un sistema para que el sujeto se comunique.

Sistemas aumentativos

Son aquellos que han sido diseñados para incrementar el habla. No suprime la verbalización ni el lenguaje oral pero no es suficiente para establecer una comunicación satisfactoria.

Características de los SAACs

- Facilitan y promueven la emisión de mensajes.
- Incrementan y refuerzan la motivación e iniciativa hacia la comunicación.
- Permiten expresar las necesidades básicas y estados de ánimo, así como una opinión acerca de un tema concreto.
- Favorecen la capacidad de expresión.
- Acercan a las personas a las ventajas que el habla conlleva.

Objetivos principales

- Proporcionar a una persona no hablante un medio eficaz de comunicación de modo que pueda convertirse en comunicador activo ya sea temporal o a largo plazo.
- Posibilitar la capacidad del habla y aumentar la fluidez comunicativa del sujeto.
- Dar lugar a una calidad de vida superior que permita desarrollar la autonomía personal y favorecer la autoestima.

Ventajas

- Contribuyen a desarrollar estrategias de comunicación y a mejorar el lenguaje oral (si lo hubiera).

- Posibilitan la socialización de la persona, ya que mejoran las relaciones interpersonales y la competencia social del sujeto.
- Reducen la ansiedad y frustración de las dificultades de comunicación.
- Evitan el aislamiento.
- Mejoran la intención y la interacción comunicativa.
- Están adaptados a nuevas tecnologías
- Representan las ideas importantes en formatos usuales que contribuyen a la comprensión (simplifican las estructuras morfosintácticas)
- Permiten formar conceptos de forma explícita.
- Son fáciles de aprender y utilizar en la vida diaria.

Desventajas

- Si el SAAC presenta cierta dificultad, es preferible reducir los interlocutores
- Poseen una unidireccionalidad comunicativa.
- Por su complejidad, la dificultad cognitiva de los enunciados disminuye.
- Perjudican, por su comodidad, el desarrollo de la capacidad verbal oral.
- Son lentos y requieren una amplitud de memoria.
- Se necesita conocer los SAACs por parte de los interlocutores para poder comunicarse entre ellos

Usuarios

Se encuentran agrupados por los diferentes tipos de trastornos que presentan, los cuales tienen la necesidad de utilizar la comunicación aumentativa o alternativa de forma transitoria o permanente.

- Personas con discapacidad física:

    1. Secuelas de parálisis cerebral
    2. Traumatismos craneoencefálicos
    3. Malformaciones craneofaciales
    4. Enfermedades neuromusculares progresivas

- Personas con discapacidad intelectual, cognitiva y física

    1. Discapacidad cognitiva y/o trastornos del lenguaje
    2. Trastornos graves del desarrollo
    3. Autismo
    4. Personas con plurideficiencias

- Personas con discapacidad sensorial

    1. Sordera
    2. Ceguera

3. Sordoceguera

- Colectivos necesitados de forma transitoria del uso de sistemas de comunicación aumentativa. Por ejemplo, personas sometidas a operaciones o lesiones de los órganos implicados en el habla o, también, desconocimiento de idiomas como pueden ser los inmigrantes.

Tipos de SAACs

Existen dos grupos claramente diferenciados: los sistemas con ayuda y los sistemas sin ayuda. Se clasifican dependiendo de si hacen uso de soportes o no, y la elección de un tipo de SAAC u otro se verá reflejada dependiendo de la necesidad de la persona.

a) SAACs con ayuda

Son mecanismos que hacen uso de soportes externos a la persona para poder facilitarle la comunicación con su entorno. En general, estos sistemas incluyen pictogramas, ortografía o escritura en soportes individualizados.

Se destacan:

- El sistema Bliss
- El sistema SPC (Símbolos pictográficos para la Comunicación)
- El sistema PEC
- Rebus, PIC, Premack
- Sistemas codificados: Braille, código Morse, etc.

b) SAACs sin ayuda

Son mecanismos mediante los cuales las personas con alguna deficiencia o carencia lingüística pueden mejorar su comunicación sin hacer uso de apoyos externos a la persona, tan sólo es necesario el cuerpo del emisor. Están estrechamente ligados a la educación y reeducación de las personas con sordera profunda prelocutiva con el objetivo principal de desarrollar la lengua oral y, posteriormente, la lengua escrita. Se destacan:

- La lengua de signos
- El sistema bimodal
- El alfabeto dactilológico
- La palabra complementada

3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA FAVORECER LA RELACIÓN SOCIAL Y LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO

3.1. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN COMUNICACIÓN

A. **Claridad**: es decir, que el mensaje que transmitimos sea entendible, por lo tanto tenemos que pronunciar las palabras vocalizando correctamente, tenemos que cuidar la velocidad, el volumen, la entonación y la fluidez del cómo hablamos. Al hablar demasiado rápido puede que no se entienda lo que se dice, pero si el ritmo es demasiado lento, se pierde la comprensión del mensaje aunque se entiendan todas las palabras.

B. **Sencillez**: hace referencia a la complejidad del mensaje. Deberemos emplear frases directas y simples que permitan a la persona reaccionar conforme las vamos nombrando. Deberemos evitar mensajes con dobles sentidos y que pueden no resultar evidentes para las personas que escuchan.

C. **Atención**: deberemos atender tanto a las expresiones verbales, como a los gestos, comportamientos o actuaciones (por ejemplo, si pone mala cara cuando le tocamos la mano..). Prestar atención a la persona dependiente es fundamental, pero también hay que demostrárselo de forma clara para que sea consciente de ello. El profesional debe de expresarle que está a su disposición para lo que necesite, que el usuario le sienta cercano y se sienta con libertad para comunicar sus preocupaciones e intereses.

D. **Empatía**: es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, lo cual facilita mucho la comunicación. No se trata de pensar o sentir igual que la persona, sino de comprenderle y manifestarle que entendemos cómo se siente. No es conveniente dar nuestra opinión sobre un tema, y mucho menos si no nos la han preguntado. Con algunas personas resulta fácil empatizar, con otras al contrario tenemos que realizar un esfuerzo, pero esto nos facilitará mucho la comunicación.

La claridad, la sencillez, la atención y la empatía son normas que mejoran la comunicación con los usuarios. Por una parte el usuario nos entiende mejor (claridad y sencillez) y por otro comprendemos mejor la realidad de quien se está dirigiendo a nosotros (atención y empatía). Todo ello ayuda a facilitar y enriquecer el proceso comunicativo obteniendo consecuencias positivas en la relación interpersonal.

3.2. PROCESO DE SELECCIÓN DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN (SAAC). RECURSOS COMUNICATIVOS.

Los SAAC mejoran las posibilidades comunicativas de las personas con problemas de comunicación. Hay SAAC muy diferentes, cada uno debe ajustarse a las características del usuario (grado de afectación motriz, psíquica...) y al entorno en el que se va a utilizar.

Proceso de selección del SAAC :

1. **Recoger información :**

- Estado de la persona y déficits que presenta.
- Intereses y actitudes personales.
- Contexto en el que se va a utilizar (en casa, fuera, con amigos, con otros profesionales..)
- Esta información la obtendremos a través de una entrevista que pasaremos a la familia y al usuario, observación directa de cómo se comunica en las diferentes situaciones, grabaciones..

2. **Toma de decisiones**:

- Tipo de SAAC más adecuado (con o sin ayuda).
- Tipo de signos que se van a utilizar y tamaño de los mismos.
- Forma de indicación (dedo, licornios, mirada..).
- Soporte que vamos a utilizar (tableros, tríptico, ordenador..).
- Selección del vocabulario.
- Forma de intervenir con el sistema seleccionado.

Requisitos que un SAAC debe cumplir:

- Permitir una amplia comunicación: conversaciones, expresar necesidades básicas...
- Ser compatible con otros aspectos de la vida del usuario (movilidad, control del entorno...)
- No limitar la comunicación.
- Ser útil en todos los contextos.
- No limitar los temas de conversación.
- Ser rápido, ágil,
- Permitir la incorporación de vocabulario nuevo.
- Ser aceptado por el usuario e interlocutores.
- Ser alcanzable en coste y mantenimiento.

De cualquier manera el uso de sistemas alternativos o complementarios es muy adecuado y, como opinan la mayor parte de los autores, no frenan la posibilidad del habla sino que, en todo caso, la potencian, favoreciendo el desarrollo del lenguaje así como la mejora global de las relaciones

interpersonales y el desarrollo cognitivo, procurando con ello el desarrollo integral de la persona.

3.3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA PARA PERSONAS CON DEFICIENCIAS SENSORIALES

Los SAACs que vamos a comentar a continuación se refieren al tipo **SIN AYUDA,** es decir, no requieren ningún utensilio ni material para desarrollarlo, el emisor utiliza su propio cuerpo.

3.3.1. LECTURA LABIO FACIAL:

Además del movimiento de los labios, también se gesticula con el rostro.

3.3.2. LA LENGUA DE SIGNOS (LS) :



Es el lenguaje natural propio de las personas con discapacidades auditivas, es una lengua con sintaxis y gramática propia. No es un conjunto de gestos y mímica, por lo que es necesario conocer los fundamentos de la lengua para poder comprender una comunicación signada.
No es una lengua universal, incluso dentro de un mismo país puede haber variaciones. (LSE Lengua de Signos Española).

Para las personas oyentes resulta difícil aprender y utilizar la LSE con la fluidez que emplea la persona sorda, sin embargo es importante que el personal sociosanitario conozca algunos gestos sencillos, con el fin de establecer contacto con ell@s. A modo de ejemplo:



En Internet tenemos muchos vídeos que nos enseñan un poco de vocabulario básico, saludos, días de la semana, meses, expresiones coloquiales; éstas son algunas referencias donde se puede aprender:

http://www.sematos.eu

http://www.youtube.com/watch?v=0KuxMcU92a4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=krkIecG_mQw&feature=related

3.3.3. EL ALFABETO DACTILOLÓGICO:

Es la representación gestual de las letras del alfabeto, cada letra tiene un signo concreto. Se utiliza para signar nombres propios, conceptos nuevos que todavía no tienen un signo asignado, direcciones. En la comunidad sorda cada persona tiene una "seña" que le identifica, para no tener que deletrear el nombre cuando se habla de él/ella. Por lo tanto se utiliza como apoyo a la LS. Y requiere un gran esfuerzo de atención.
Una explicación con imágenes en vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=AYLBp9QbaJY&NR=1
http://www.sematos.eu

3.3.4. LA PALABRA COMPLEMENTADA

Consta de lectura labio facial y el apoyo del gesto manual. La lectura labio facial resulta muy difícil , hay consonantes de similar pronunciación ("P" y "B"...) La posición de la mano ayuda a diferenciarlas.

3.3.5. EL SISTEMA BIMODAL

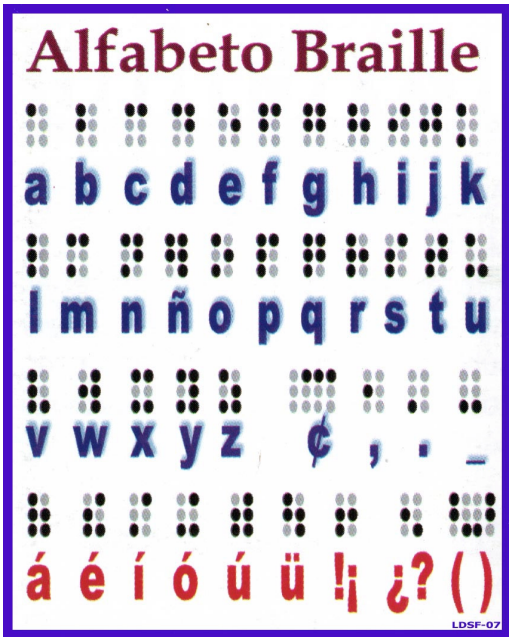
Supone el uso simultáneo de la LS y la palabra hablada. El objetivo es promover el desarrollo de la lengua oral. La estructura sintáctica que sigue es la del lenguaje oral, puesto que se considera que la LS apoya a la palabra hablada y no al revés. (Entre la comunidad de personas sordas no está bien aceptada).

3.3.6. EL BRAILLE

Es un SAAC **CON AYUDA**. Es un sistema de lectura en relieve para personas con **déficit visual**, se percibe de forma táctil.

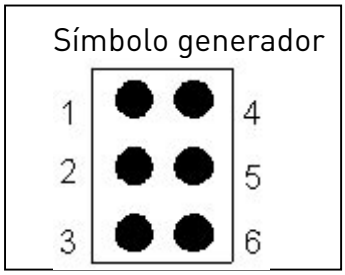
El sistema fue creado por Louis Braille (Francia 1823), fue difundido rápidamente por ser sencillo y manejable. Cada letra, número o signo de puntuación se representa por un signo formado por 6 puntos, estos puntos se combinan hasta dar lugar a 63 combinaciones diferentes. El signo matriz a

partir del cual se genera cada carácter del Braille se denomina **símbolo generador.**



La lectura del Braille se realiza letra a letra, por lo que al principio puede resultar lento y requiere mucha concentración.

La escritura en Braille puede realizarse a mano (con una pauta o regleta y un punzón) o bien a máquina: máquina Perkins, que posee un teclado con 6 teclas , cada una corresponde a uno de los puntos del símbolo generador.



Las personas sordociegas tienen importantes dificultades de relación y una tendencia natural al aislamiento. Existen grandes diferencias entre las personas que son sordociegas de nacimiento (que no poseen referencias visuales ni auditivas) y **aquellas que aún presentando un déficit sensorial de nacimiento ha podido utilizar el otro canal de información**. Estas personas podrán utilizar códigos alfabéticos y no alfabéticos. Destaca el **DACTILOLÓGICO en PALMA,** y el Braille. Además podemos utilizar la L.S. con apoyo táctil, el método TADOMA y el sistema DACTYLIS.

a) el **DACTILOLÓGICO en PALMA**: Se utiliza como método en aquellas personas que conocen la escritura en tinta. Consiste en escribir con el dedo índice las letras de cada palabra, en mayúsculas, sobre la palma de la mano siguiendo el trazado de la escritura con tinta.

b) **TADOMA**: es un sistema para enseñar a hablar a partir de la percepción táctil de las vibraciones que produce la voz y de la percepción de los músculos de la cara. La persona sordociega coloca las manos sobre los labios y el rostro de su interlocutor para captar el mensaje y poder imitarlo.

c) **Sistema DACTYLIS** creado por Daniel Álvarez en el 2000 (sordo desde los 4 años y ciego a los 30 años, presidente de la Asociación Española de Sordociegos). Utiliza el dactilológico con signos de la LSE adaptados

para ser signados entre la palma de la mano y el antebrazo. Este sistema aporta mayor fluidez y agilidad para las personas que se desenvuelven correctamente con el dactilológico.



3.4. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES FÍSICAS, MOTRICES Y PSÍQUICAS

3.4.1. SISTEMA BLISS

El Bliss se creó en principio como sistema internacional de comunicación, pero es usado sobre todo en personas con parálisis cerebral. Los símbolos que componen el sistema están separados en seis categorías: verbos, nombres, personas, descriptivos, sociales y misceláneos (diversos términos). Consta de tarjetas con dibujos pero sin palabras, de diversos colores dependiendo si son personas, acciones..., algunas con un gran parecido con la realidad, otras sugieren la idea, por ejemplo: arriba, abajo. El sistema no recomienda una metodología para ser enseñado sino que dependerá de las características del sujeto, por ejemplo podemos asociar las tarjetas a los objetos que representan,

para que una vez que la asociación se produzca ir retirando el objeto. Para utilizar este sistema es necesario que la persona posea buena discriminación visual y habilidades cognitivas básicas para iniciar la comunicación con los otros. Este sistema posee la ventaja de contener símbolos para artículos, preposiciones, tiempos verbales,.. de modo que los convierte en un sistema de comunicación con una estructura lingüística muy similar a la del lenguaje oral.

1. CLASES DE SÍMBOLOS:

1.1. Símbolos pictográficos. — Su forma nos recue da las palabras o conceptos que representa.



FIG. — *Oreja.*



FIG. 2. — *Nariz.*

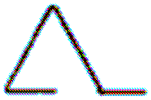


FIG. 3. — *Piernas.*

1.2. Símbolos ideográficos. — Bliss concibió e tos símbolos fundamentándose en la escritura ide gráfica china.



FIG. 4. — *Contento.*

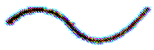


FIG. 5. — *Agua.*

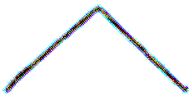


FIG. 6. — *Protección.*

1.3. Símbolos internacionales. — Son signos universales, reconocidos y utilizados en todos los países.



FIG. 7. — *Más.*



FIG. 8. — *Por.*



FIG. 9. — *Arriba.*

1.4. Símbolos arbitrarios o abstractos. — Son aquellos que no guardan una especial relación con las ideas o conceptos que representan.



FIG. 10. — *Él.*



FIG. 11. — *Un.*



FIG. 12. — *Aquí.*

3.4.2. SISTEMAS SPC

El SPC tiene como objetivo principal facilitar la comunicación en sujetos no orales con dificultades motoras y auditivas. El vocabulario que se utiliza en este sistema utiliza la misma diferenciación de categorías y colores que el sistema Bliss. Consta de pequeñas tarjetas con dibujos muy sencillos y representativos para la persona que están acompañados de la palabra escrita, se pueden fotocopiar en diferentes colores dependiendo si representan personas, verbos... también podemos añadir otros que no tenga el sistema y que consideremos útiles para ella. El vocabulario es más restringido que en el sistema Bliss, aunque dada su simplicidad es muy fácil de aprender.
Para llevar a la práctica este sistema se eligen los símbolos según el nivel de la persona y se colocan sobre un tablero, para seleccionar este vocabulario inicial se tienen en cuenta, ante todo, las tarjetas con sus necesidades básicas (aseo, alimentación...), las actividades cotidianas y sus gustos o preferencias. Después se van incorporando al vocabulario existente aquellas palabras que vaya necesitando cada persona a medida que van cambiando sus necesidades comunicativas. Entonces le enseñaremos a encadenar palabras para ir formando frases.

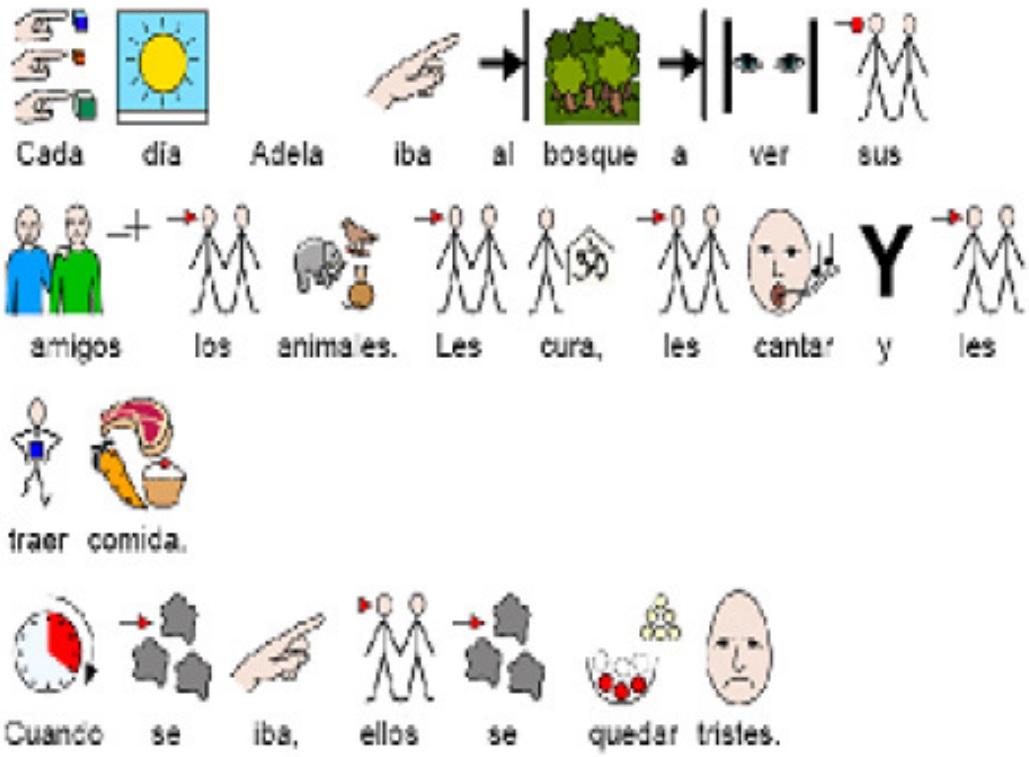




Figura 1: Ejemplo lenguaje SPC

3.4.3. EL SISTEMA PREMACK

Fue empleado en EEUU y Gran Bretaña, utiliza fichas de plástico o de madera con diferentes colores, tamaños y formas, fue utilizado con personas con discapacidad intelectual.

3.5. AYUDAS TÉCNICAS EN LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA. AYUDAS PARA LA INFORMACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN

Ayuda técnica para la comunicación: todo instrumento mecánico o electrónico diseñado para que la persona pueda comunicarse mejor, ya sea aumentando o bien supliendo su habla oral (Soro•Camats, 1998).

La ayuda técnica elegida debe:
. Posibilitar al sujeto con discapacidad motora la producción de la información que elabora mentalmente.
· Facilitar la función de contacto entre emisor y receptor, de la forma mas rápida y eficaz posible.
· Hacer posible la comunicación en todas las circunstancias y de un modo independiente.

3.5.1. PRODUCTOS DE APOYO BÁSICOS



Los tableros de comunicación: son superficies planas divididas en casillas sonde se colocan símbolos, signos, dibujos, fotografías, palabras... dependiendo el sistema (SPC, Bliss..) que utilice el usuario. El usuario señalará el símbolo con el dedo, la mirada o con un puntero o licornio (varilla que se acopla a la cabeza de aquellas personas que tienen afectados los brazos, también se puede acoplar a la boca). Los tableros pueden ser: trípticos, cuadernos, hules, o paneles. (ver imágenes del SPC y Bliss)

3.5.2. PRODUCTOS DE APOYO MECÁNICOS O ELECTRÓNICOS SENCILLOS:



-**El Señalador de Reloj**: es un dispositivo eléctrico formado por un panel con una aguja y los símbolos dispuestos en círculo, como las horas de un reloj, la aguja se mueve mediante un pulsador que la persona mantiene accionado hasta que señala el símbolo deseado.

-**Comunicador electrónico** :Es un dispositivo en forma de maletín con un panel frontal dividido en casillas sobre las que se colocan los símbolos, dibujos, colores...Debajo del panel hay un dispositivo de luz que el usuario acciona con un pulsador, o on el dedo. Es de fácil transporte.

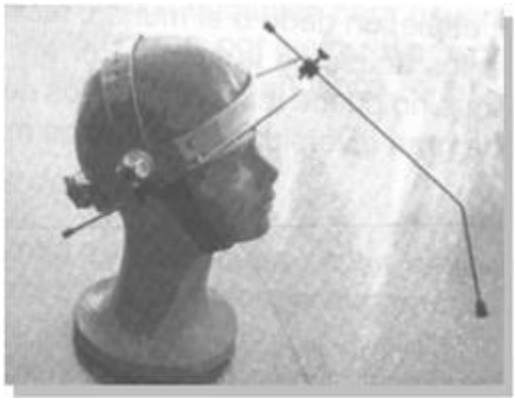


3.5.3. PRODUCTOS DE APOYO ELECTRÓNICOS DE ALTA TECNOLOGÍA

- **Comunicadores electrónicos** : la diferencia con el anterior es que estos poseen voz digital o sintetizador. Los mensajes previamente se graban. Pueden emitir mensajes de más extensos aunque no hay posibilidad de crear mensajes espontáneos. Entre ellos:

Comunicadores: Alphatalker	Comunicadores: Deltatalker
	

- **Adaptadores para el ordenador:** teclados alternativos para el ordenador, tarjetas de voz, sintetizadores de voz, pulsadores (para la señalización directa: licornio, que se coloca en la cabeza, varilla bucal, pulsadores de soplo, de vibración, de parpadeo...). También programas que permiten utilizar el Bliss y el SPC.













En esta página web se pueden ver más productos de apoyo

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/30.htm

En cuanto al **sofware**, existen diferentes programas diseñados para el uso de productos de apoyo para la comunicación, como el MINSPEAK, SICLA 2.0 (Sistema Comunicador de Lenguajes Alternativos) el Borrad Maker y el Bildbas pictograma 4.0.

PRODUCTOS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

a) Para personas con ceguera o déficit visual

- Productos básicos:
  - Bastones
  - Lupas, gafas especiales
  - Atriles
  - Instrumentos para el dibujo manual
  - Pautas y punzones para la escritura en Braille
  - Metros, enhebradores

- Mecánicas o de baja tecnología
  - Máquina Perkins (para escribir en Braille)
  - Lectores de CD: DAISY que permiten reproducir audio libros,
  - Pantallas de ordenador de mayor tamaño
  - Relojes, despertadores, balanzas de cocina
  - Grabadoras de 4 pistas

- Electrónicas o de alta tecnología
  - De acceso al ordenador:
    - Magnificadores de pantalla
    - Lectores de pantalla
    - Lçinea Braille
  - Destinados a leer textos en tinta:
    - Lupas TV
    - Impresoras en Braille
    - Programas OCR
    - Sistemas compactos de lectura de textos
  - Programas para acceder al teléfono móvil.

b) Productos de apoyo para personas sordas o con deficiencias auditivas

- Productos básicos:
  - Audífonos, auriculares, altavoces despertadores, relojes

- **Mecánicos o de baja tecnología:**
  - Aparatos para reconocer los sonidos de la casa
  - Para entender una conversación
    - - teléfonos adaptados
    - - aparatos que se conectan a los audífonos
  - Para entender una información del tv., equipo de música
  - Teléfonos de texto (OTICON), Fax

- **Ayudas de alta tecnología**
  - Videoteléfonos
  - Teléfonos móviles
  - Internet

c) Productos de apoyo para personas sordociegas

Las ayudas técnicas dependerán del resto visual y auditivo . Estas personas van a tener que utilizar ayudas con salida en Braille.
Existen dispositivos electrónicos que están diseñados para las necesidades de las personas sordociegas que manejan Braille. Son aparatos con doble pantalla y doble teclado uno en Braille y otro convencional. El SCREEN BRAILLE COMNUICATOR es de pequeño tamaño y fácil manejo.



PRODUCTOS DE APOYO PARA PERSONAS CON ELA

Con grado de afectación leve
Disartria leve a moderada. Sin compromiso o compromiso leve en miembros superiores o inferiores. Apoyo técnico recomendado: uso de cuaderno o pizarra.

Con grado de afectación moderado
Disartria moderada a severa**.** Sin compromiso o compromiso leve en miembros superiores o inferiores. Apoyos técnicos: Uso de pizarras, programas para ordenador: PREDICE; tableros de comunicación: alfabético y pictogramas; comunicadotes: Cannon y Lightwritter.

Con grado de afectación severo
Anartria. Compromiso severo en miembros superiores e inferiores. Apoyos técnicos: Programas para ordenador y tableros de comunicación (alfabético, pictogramas).

3.6. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN DE LA EVOLUCIÓN GENERAL DE LA PERSONA CON DEPENDENCIA

La observación la pueden realizar diferentes personas, pero el auxiliar a domicilio puede realizar esta tarea perfectamente, ya que habitualmente mantiene contacto con el usuario, lo que le permite una observación frecuente y completa de los diferentes aspectos (estado de ánimo, estado de salud, evolución funcional en las AVD). Además, la cotidianidad hace que el usuario se relaje y actúe de forma espontánea. El auxiliar, por otro lado, no tiene una carga emocional tan fuerte como la que pueden tener los familiares.

Para comprobar la evolución general de la persona con dependencia, el auxiliar utilizará técnicas de observación estructuradas y no estructuradas para registrar y recopilar la información de manera sencilla, que posteriormente transmitirá al equipo interdisciplinar. Estos registros permitirán realizar un seguimiento de la evolución comunicativa del usuario, observar si el SAAC es adecuado y/o planificar las posteriores intervenciones.

Problemas de comunicación oral a observar:

- En la comunicación oral
  - A la persona le cuesta encontrar las palabras adecuadas.
  - Cambia unas palabras por otras al expresarse.
  - Se inventa palabras.
  - Presenta problemas de atención en la conversación.
  - Tiene dificultades para expresar deseos, necesidades y se bloquea.
  - Presenta falta de iniciativa en la comunicación
  - Se frustra a menudo cuando se comunica.
  - Presenta dificultades en la articulación del lenguaje.

- En la comunicación no verbal
  - Ver si los mensajes verbales y no verbales van en consonancia: atender la mirada, la expresión facial, los gestos corporales, el contacto físico...

Algunos aspectos a observar sobre la utilización de los SAACs:

- Con qué interlocutores utiliza el SAAC para comunicarse y en qué entornos.

- En qué situaciones puede utilizar el SAAC.
- Si el vocabulario se adecua a sus necesidades.
- Si puede señalar los símbolos de forma clara y ágil.
- Señales de comunicación que está utilizando el usuario y no se están considerando.

Ejemplo de Ficha de observación del ámbito relacional y de comunicación:

Usuario:
Auxiliar:
Fecha:

Interlocutores: Personas con las que se comunica y frecuencia (a diario, frecuentemente, ocasionalmente, casi nunca)

Lugares: ¿ dónde se comunica?

Utilidad: ¿ puede utilizar el SAAC en todos los contextos, (personas, lugares, momentos) en los que se desenvuelve?

Símbolos o signos: ¿son adecuados, hay alguno que no emplee, qué otros puede necesitar?

Indicación: observaciones con respecto a la forma de indicación (agilidad, rapidez,)

Otros recursos comunicativos : describir el contexto y cuándo los utiliza

Actitud general:

- Muy poco motivado
- Poco motivado
- Solo se comunica si es estrictamente necesario
- Busca diferentes posibilidades de comunicación
- Otros

Comentarios:

3.7. SENSIBILIDAD ANTE LOS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA

El trabajo con personas con dependencia en los domicilios es complejo y en muchas ocasiones pone a prueba los conocimientos, las experiencias y los recursos personales del auxiliar.

El estar en el domicilio supone ventajas, porque la persona está en su ambiente, pero también conlleva limitaciones puesto que las interacciones comunicativas quedan reducidas a las personas de su propia vivienda o del entorno más cercano.

Además el usuario puede verse afectado por trastornos que le limiten sus posibilidades comunicativas (Alzheimer, demencias, Parálisis Cerebral, ...) e incluso pueden desembocar en un desinterés por hacerlo. Por este motivo el auxiliar debe mostrar sensibilidad hacia los problemas de comunicación de cada uno de los usuarios, lo cual requiere cualidades personales y capacidad de poner en práctica ciertas actitudes ante los problemas de comunicación de los usuarios.

La sensibilidad es una cualidad personal que permite percibir y comprender de forma natural las emociones y necesidades de los otros.

Entre las **actitudes que permitan expresar sensibilidad hacia los problemas de comunicación de la persona con dependencia**, destacan:

- Hacer uso de estrategias para favorecer su comunicación (empatía, escucha activa y asertividad).
- Mostrar paciencia y respeto.
- Dar tiempo a la persona con NEC.
- Conocer y practicar el SAAC de la persona con dependencia.